

1. Mulher de 32 anos com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, apresenta edema em membros inferiores, hipertensão arterial e proteinúria significativa detectada em exames laboratoriais. Uma biópsia renal revelou características compatíveis com glomerulonefrite lúpica. Qual mecanismo imunológico é o principal responsável pelo dano renal observado nessa condição?

- A. Destruição direta de células epiteliais por linfócitos T citotóxicos.
- B. Estímulo excessivo da resposta humoral pela IL-10.
- C. Apoptose de células mesangiais mediada por TNF-alfa.
- D. Deposição de complexos imunes nos glomérulos.

Alternativa Correta: **(D)** Embora o LES tenha participação de linfócitos T auxiliares na amplificação da resposta autoimune, não há destruição direta das células epiteliais dos glomérulos pelos linfócitos T citotóxicos. No LES, o dano renal ocorre principalmente por deposição de complexos imunológicos e ativação do complemento, não por uma citotoxicidade mediada diretamente por linfócitos T. A IL-10 é uma citocina imunomoduladora que pode estimular a resposta humoral ao favorecer a diferenciação de linfócitos B e a produção de autoanticorpos, mas não é diretamente responsável pelo dano glomerular no LES. O TNF-alfa tem um papel pró-inflamatório e pode contribuir para o processo inflamatório no LES, mas não é o principal mediador do dano renal lúpico.

Bibliografia: ROBBINS, S. L.; KUMAR, V. (ed.); ABBAS, A.K. (ed.); FAUSTO, N. (ed.). Patologia: Bases Patológicas das doenças. 9^a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.; ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. H. I. V. Imunologia celular e molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. .

2. A gametogênese e a fertilização são processos fundamentais para a reprodução humana. Com base nesses processos, escolha a opção que apresenta a afirmação correta.

- A. A espermatogênese ocorre nos túbulos seminíferos e produz espermatozoides haploides, enquanto a ovulogênese ocorre nos ovários e forma óvulos diploides.
- B. A fertilização ocorre no útero, onde o espermatozoide penetra no óvulo, restabelecendo a diploidia e formando o zigoto.
- C. Durante a meiose I, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, resultando em células com metade do número de cromossomos da espécie.
- D. A ovulogênese é um processo contínuo que se inicia na puberdade e termina na menopausa, produzindo um óvulo maduro a cada 28 dias.

Alternativa Correta: **(C)** A fertilização ocorre na tuba uterina (trompa de Falópio), não no útero. É nesse local que o espermatozoide penetra no óvulo, restabelecendo a diploidia e formando o zigoto; A ovulogênese não é um processo contínuo. Ela começa ainda no desenvolvimento embrionário, com a formação de folículos primordiais, mas é interrompida até a puberdade. Após a puberdade, um óvulo maduro é liberado a cada ciclo menstrual, mas o processo não é contínuo, pois os folículos são formados ainda durante a vida fetal; A ovulogênese produz óvulos haploides, não diploides. Além disso, a espermatogênese ocorre nos túbulos seminíferos, mas a ovulogênese ocorre nos ovários, formando óvulos haploides.

Bibliografia: MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. Embriologia Clínica. 10^a ed. Elsevier, 2019.; SADLER, T. W. Langman: Embriologia Médica. 13^a ed. Guanabara Koogan, 2019.; ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula. 6^a ed. Artmed, 2017.

3. Um homem de 58 anos, com histórico de hepatite C crônica, apresenta fadiga e aumento do volume abdominal. Exames de imagem revelam irregularidade na superfície hepática e presença de múltiplos nódulos regenerativos. A biópsia confirma a presença de tecido fibroso intercalado entre os nódulos regenerativos hepáticos. Esse quadro clínico representa um exemplo clássico de um processo em que há tentativa de regeneração hepática. Diante deste cenário, qual dos processos abaixo está envolvido nessa resposta tecidual?

- A. Proliferação de hepatócitos para tentar restaurar a estrutura e função hepática, embora o processo seja desorganizado devido à fibrose.
- B. Substituição do tecido hepático normal por tecido conjuntivo denso, promovendo a restauração completa da função hepática.
- C. Ativação de fibroblastos e formação de um arcabouço extracelular permanente, facilitando a regeneração ordenada do parênquima hepático.
- D. Deposição de colágeno e formação de tecido cicatricial sem recuperação funcional total, permitindo a reconstituição da arquitetura hepática original.

Alternativa Correta: **(A)** Em doenças hepáticas crônicas, como a cirrose, o fígado tenta regenerar-se por meio da proliferação de hepatócitos. No entanto, a fibrose impede a reestruturação adequada do órgão, resultando na formação de nódulos regenerativos desorganizados. Embora haja regeneração celular, a presença de septos fibróticos distorce a arquitetura hepática, comprometendo a função do fígado. A deposição de colágeno e a formação de tecido cicatricial fazem parte do processo de fibrose, que ocorre em resposta à lesão crônica. No entanto, ao contrário do que a alternativa sugere, esse processo não permite a reconstituição da arquitetura hepática original. Na verdade, a fibrose desorganiza a estrutura hepática e dificulta a regeneração eficiente, levando à disfunção progressiva do órgão. A substituição do tecido hepático normal por tecido conjuntivo denso ocorre na fibrose avançada e na cirrose, mas esse processo não restaura a função hepática, pelo contrário, prejudica ainda mais o funcionamento do órgão. A fibrose leva à formação de nódulos regenerativos sem organização funcional adequada, o que resulta na perda progressiva da capacidade do fígado de desempenhar suas funções metabólicas e desintoxicantes. A ativação de fibroblastos e a deposição da matriz extracelular são eventos característicos da fibrose hepática. Entretanto, esse arcabouço não facilita a regeneração ordenada do fígado, pelo contrário, ele forma barreiras físicas entre os hepatócitos, desorganizando a estrutura hepática e dificultando a recuperação funcional do órgão.

Bibliografia: KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul K.; ASTER, Jon C. Patologia: Bases Patológicas das Doenças. 10th ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. ; ROBBINS, Stanley L.; COTRAN, Ramzi S. Robbins e Cotran Pathologic Basis of Disease. 10th ed. Elsevier, 2021..

4. As mudanças epigenéticas, incluindo a metilação do DNA e modificação da histona, estão frequentemente associadas com o câncer. Acredita-se que a hipermetilação contribua para o câncer ao:

- A. Inibir a replicação do DNA.
- B. Estimular a tradução dos oncogenes.
- C. Inibir a expressão dos genes supressores de tumor.**
- D. Estimular a telomerase.

Alternativa Correta: **(C)** Vários estudos observaram que, embora o nível geral de metilação do DNA seja menor nas células de câncer, algumas ilhas CpG específicas têm metilação extra (são hipermetiladas). Por exemplo, um estudo descobriu que 5 a 10 % de ilhas CpG normalmente não metiladas localizadas em promotores se tornam anormalmente metiladas nas células de câncer. Esse excesso de metilação pode inibir a transcrição de genes supressores de tumor, assim, estimulando o desenvolvimento do câncer.

Bibliografia: PIERCE, Benjamin A. Genética - Um Enfoque Conceitual, 5th edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. E-book. p.594. ISBN 9788527729338.

5. Um paciente de 65 anos com osteoartrite é tratado com naproxeno para controle da dor. Após algumas semanas, ele apresenta episódios de pirose intensa e desconforto epigástrico. Qual é o mecanismo desse efeito adverso promovido pelos anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs)?

- A. Inibição da COX-2, com aumento da secreção ácida pelas células parietais.
- B. Inibição da COX-1, com diminuição da síntese de prostaglandinas gastroprotetoras.**
- C. Inibição da liberação de histamina com menor ativação dos receptores H2 do estômago.
- D. Inibição da COX-1, com bloqueio da produção de muco gástrico mediada por acetilcolina.

Alternativa Correta: **(B)** A inibição da COX-1 reduz a síntese de prostaglandinas protetoras no estômago, levando a menor secreção de muco e bicarbonato, bem como redução da inibição da secreção ácida pelas células parietais. Estes efeitos são mediados diretamente pela ativação dos receptores de prostaglandinas e sua redução aumenta a susceptibilidade à lesão gástrica e ao desenvolvimento de úlceras.

Bibliografia: NUCCI, Gilberto D. Tratado de Farmacologia Clínica. Grupo GEN, 2021. ; RANG, H. P.; DALE, M. Maureen et al. Rang e Dale farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

6. O potencial de ação dos neurônios ocorre devido uma redistribuição de carga elétrica através de membrana celular. Durante o potencial de ação, a despolarização e repolarização da célula são causadas respectivamente por:

- A. influxo de íons de sódio e efluxo de íons potássio.**
- B. influxo de íons de potássio e efluxo de íons sódio.
- C. efluxo de íons de sódio e influxo de íons potássio
- D. efluxo de íons de potássio e influxo de íons sódio.

Alternativa Correta: **(A)** Influxo de íons de sódio através da membrana e a repolarização é causada pelo efluxo de íons potássio, pois, durante a despolarização do potencial de ação, canais de sódio voltagem-dependentes se abrem, permitindo a entrada rápida de sódio na célula. A repolarização ocorre em seguida devido à abertura dos canais de potássio, permitindo a saída de potássio.

Bibliografia: GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 14^a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021.

7. Um paciente faz uso prolongado de prednisona, um glicocorticoide. A principal via de ação desses fármacos envolve:
- A. bloqueio direto dos receptores H1 da histamina, reduzindo a resposta alérgica brônquica.
 - B. inibição irreversível da ciclo-oxigenase-2 (COX-2), reduzindo a síntese de prostaglandinas inflamatórias.
 - C. supressão da expressão de genes pró-inflamatórios por meio da ligação a receptores nucleares.**
 - D. aumento da liberação de prostaglandinas anti-inflamatórias pelas células epiteliais brônquicas.

Alternativa Correta: **(C)** Os glicocorticóides ligam-se a receptores intracelulares e modulam a transcrição gênica, suprimindo a expressão de citocinas pró-inflamatórias e aumentando a síntese de proteínas anti-inflamatórias, como a lipocortina-1. As demais alternativas descrevem mecanismos de outros fármacos. *Bibliografia: RANG, H. P.; DALE, M. Maureen et al. Rang e Dale farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020. xviii, 789 p. ISBN 978-85-9515-1192.*

8. O reflexo barorreceptor regula a pressão arterial através de estímulos aferentes que chegam ao tronco encefálico. Quais nervos cranianos participam desse reflexo?
- A. Nervo trigêmeo (V) e nervo facial (VII).
 - B. Nervo vago (X) e nervo acessório (XI).
 - C. Nervo olfatório (I) e nervo óptico (II).
 - D. Nervo glossofaríngeo (IX) e nervo vago (X).**

Alternativa Correta: **(D)** Nervo glossofaríngeo (IX) e nervo vago (X), pois o reflexo barorreceptor envolve a detecção de variações na pressão arterial pelos barorreceptores localizados no seio carotídeo e no arco aórtico. O nervo glossofaríngeo (IX) conduz os estímulos aferentes do seio carotídeo até o tronco encefálico, enquanto o nervo vago (X) transmite os sinais do arco aórtico. Esses sinais são processados no centro vasomotor do bulbo, ajustando a atividade autonômica para regular a pressão arterial.

Bibliografia: MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia Orientada para a Clínica. 8^a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

9. Um paciente com infecção cutânea por *Staphylococcus aureus* resistente à metilina (MRSA) é tratado com vancomicina. Após a infusão rápida do fármaco, ele desenvolve eritema difuso, rubor facial e prurido intenso. Qual é o mecanismo envolvido nessa reação adversa?
- A. Liberação de histamina por degranulação mastocitária independente de IgE.**
 - B. Ativação do sistema complemento, causando vasodilatação generalizada.
 - C. Formação de imunocomplexos circulantes, desencadeando resposta inflamatória.
 - D. Deposição do fármaco na derme, ativando macrófagos residentes.

Alternativa Correta: **(A)**

A reação conhecida como "Síndrome do Homem Vermelho" ocorre devido à liberação de histamina por degranulação mastocitária não mediada por IgE, frequentemente associada à infusão rápida de vancomicina. A ativação do complemento pode causar inflamação, mas não está diretamente envolvida nessa reação adversa. A formação de imunocomplexos está associada a reações imunomediadas, como doença do soro, o que não ocorre nesse caso. O fármaco não se deposita na derme, e a ativação de macrófagos não é a causa dessa reação adversa.

Bibliografia: BRUTON, L. L.; HILAL-DANDAN, R.; KNOLLMANN, Bjorn C. As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e Gilman. 13. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. ISBN 9788580556155.

10. O estado do hospedeiro é de fundamental importância na determinação da patogenicidade de fungos oportunistas, como *Candida spp.* Existem fatores associados a *Candida spp.* que podem ser considerados fatores de virulência, por contribuírem para o processo patológico. Assinale a alternativa que contém um desses fatores
- A. A aderência da *Candida spp.* a diversos tecidos e superfícies inanimadas por meio de fímbrias.**

- B. A resistência a antibióticos de amplo espectro, devido à presença de plasmídeos de resistência.
- C. A produção de cápsula que confere evasão ao sistema imune, impedindo sua fagocitose.
- D. Possibilidade de sofrer dimorfismo devido a alterações no microambiente, como mudanças no pH e temperatura.

Alternativa Correta: **(D)** A *Candida* não é capaz de produzir fímbrias e nem cápsula. Os antibióticos não agem sobre as leveduras e, sim, sobre as bactérias.

Bibliografia: MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K. S.; PFALLER, M. A. *Microbiologia médica*. 7. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014..

11. Na neurofibromatose tipo 1, a deficiência da neurofibromina leva à ativação constante da via RAS. Marque a alternativa que indica a principal consequência dessa ativação sustentada nessa doença.

- A. Aumento da proliferação celular e predisposição ao desenvolvimento de tumores.
- B. Indução da apoptose, resultando em morte celular programada.
- C. Inibição do ciclo celular na fase G0, reduzindo a proliferação das células de Schwann.
- D. Redução da expressão de fatores de crescimento e limitação da angiogênese.

Alternativa Correta: **(A)** A neurofibromatose tipo 1 (NF1) resulta de mutações no gene NF1, que codifica a neurofibromina, uma proteína que inibe a via RAS/MAPK ao converter RAS ativo (RAS-GTP) em sua forma inativa (RAS-GDP). A perda da neurofibromina leva à ativação sustentada dessa via, promovendo proliferação celular descontrolada e predisposição ao desenvolvimento de neurofibromas e outros tumores. A ativação crônica de RAS não induz diretamente a apoptose, mas seu efeito varia conforme o contexto celular. Em células normais, pode desencadear senescência celular como defesa contra oncogênese. Já em pacientes com NF1, a ativação contínua da via RAS/MAPK favorece a proliferação celular e resistência à apoptose, contribuindo para o crescimento tumoral. Além disso, a via RAS/MAPK não bloqueia o ciclo celular na fase G0; pelo contrário, estimula sua progressão, especialmente nas transições G1/S e G2/M, aumentando a proliferação celular. A falta de neurofibromina desregula esse processo, tornando as células mais propensas ao crescimento descontrolado. Por fim, a ativação da via RAS/MAPK aumenta, e não reduz, a expressão de fatores de crescimento e angiogênese. Em tumores associados à NF1, ocorre superexpressão do VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), promovendo a vascularização tumoral e a progressão dos neurofibromas para formas mais agressivas.

MCINNES, R. R.; WILLARD, H. F.; NUSSBAUM, R. Thompson & Thompson *Genética Médica*. 8. ed. [s.l.] Elsevier Editora Ltda, 2016. Alberts, B. et al. (Orgs.). *Biologia Molecular da Célula* - 6ª Ed. 2017, Ed. Artes Médicas, Porto Alegre.

12. Uma criança de 7 anos apresenta tosse seca, febre baixa e sibilância. O hemograma revela eosinofilia, e a radiografia torácica mostra infiltrado migratório. Há relato de eliminação de vermes nas fezes. Após o diagnóstico de ascaridíase, o tratamento é iniciado. Assinale a afirmativa que melhor descreve a patogenia da doença.

- A. Os vermes adultos no intestino liberam toxinas que causam lesões inflamatórias pulmonares.
- B. A resposta imunológica aos ovos ingeridos é a principal responsável pelos sintomas respiratórios.
- C. A fase pulmonar da doença é causada pela reinfecção endógena das larvas que permanecem nos pulmões.
- D. A migração das larvas pelo pulmão provoca uma reação inflamatória com eosinofilia e sintomas respiratórios.

Alternativa Correta: **(D)** A migração das larvas pelo pulmão provoca uma reação inflamatória com eosinofilia e sintomas respiratórios. Na ascaridíase, os ovos ingeridos no alimento ou na água contaminada eclodem no intestino, liberando larvas que atravessam a parede intestinal. Elas migram pela circulação até os pulmões, onde causam inflamação local devido à resposta imunológica, frequentemente associada à eosinofilia. Esse processo explica os sintomas respiratórios, como tosse e sibilância, e os achados de infiltrados pulmonares. Os vermes adultos no intestino não têm relação direta com a fase pulmonar da ascaridíase. Eles podem causar obstrução intestinal, desnutrição e irritação local, mas não liberam toxinas que afetam os pulmões. Não há reinfecção endógena nos pulmões. As larvas que chegam aos pulmões fazem parte de um ciclo normal da parasitose. Após sua maturação, elas são deglutidas e retornam ao intestino, onde completam o ciclo de vida. Os sintomas respiratórios estão associados à inflamação causada pela migração das larvas nos pulmões e não diretamente aos ovos ingeridos. A resposta aos ovos ocorre no intestino, onde eles eclodem.

Bibliografia: NEVES, DP. *Parasitologia Humana*, 14ª ed., São Paulo, Atheneu, 2022. REY, L. *Bases da Parasitologia Médica*. 3a. Edição, Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2011.

13. Algumas espécies de *Escherichia coli* promovem lesão enteropatogênica que leva a disfunção da absorção intestinal. Qual é o tecido e a estrutura lesionados, respectivamente, nessa condição?

- A. Tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado / vaso sanguíneo.
- B. Tecido epitelial de revestimento simples colunar com microvilos / microvilos.

- C. Tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado / Placa de Peyer.
- D. Tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso/ camada córnea.

Alternativa Correta: **(B)** Tecido que reveste o intestino e é onde a bactéria vai agir, os microvilos são degradados dificultando a absorção.

Bibliografia: JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J.; HISTOLOGIA BÁSICA. RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 2005.

14. Um cirurgião prepara o campo para realizar cirurgia óssea em região diafisária de fêmur. Os tecidos incisionados em ordem são:
- A. tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso córneo, tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado, tecido adiposo multilocular, tecido muscular estriado esquelético.
 - B. tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso córneo, tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado, tecido adiposo unilocular, tecido muscular estriado esquelético.**
 - C. tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso, tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado, tecido adiposo unilocular, tecido muscular liso.
 - D. tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso, tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado, tecido adiposo unilocular, tecido muscular estriado esquelético.

Alternativa Correta: **(B)** Esses são os tecidos da estratigrafia normal. Multilocular mais abundante em feto e não existe na coxa. Tecido de pele é sempre estratificado e não simples. O conjuntivo denso modelado só em tendões.

Bibliografia: JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J.; HISTOLOGIA BÁSICA. RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 2005.

15. A estabilidade articular dos membros inferiores é garantida por estruturas anatômicas que atuam de forma estática e dinâmica para manter a postura e permitir mobilidade segura. Assinale a alternativa correta quanto a estrutura responsável pela estabilidade dinâmica do joelho.
- A. Ligamento cruzado anterior.
 - B. Músculo quadríceps femoral.**
 - C. Ligamento colateral lateral.
 - D. Menisco lateral.

Alternativa Correta: **(B)** A estabilidade dinâmica do joelho é controlada principalmente pela ação muscular, e o músculo quadríceps femoral desempenha um papel fundamental no controle da posição da patela e na resistência ao impacto durante a marcha e atividades de carga. Já os ligamentos cruzado anterior e colateral lateral atuam na estabilização estática, limitando deslocamentos excessivos. O menisco lateral auxilia na absorção de impacto e congruência articular, mas não é a principal estrutura responsável pela estabilidade dinâmica.

Bibliografia: MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia Orientada para a Clínica. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

16. Em relação ao desenvolvimento embrionário do sistema cardiovascular, é correto afirmar que:
- A. o coração começa a bater no final da quarta semana de gestação.
 - B. sistema cardiovascular se forma a partir do ectoderma durante a segunda semana.
 - C. o tubo cardíaco se forma a partir do mesoderma lateral durante a terceira semana.**
 - D. a separação dos átrios e ventrículos ocorre durante a sexta semana.

Alternativa Correta: **(C)** O tubo cardíaco se forma a partir do mesoderma lateral durante a terceira semana e começa a bater no final dessa semana. O coração começa a bater no final da terceira semana, e não da quarta. O sistema cardiovascular não se forma a partir do ectoderma, mas sim do mesoderma lateral. A separação dos átrios e ventrículos ocorre antes da sexta semana, por volta da quinta semana.

Bibliografia: MOORE, Keith L.; PERSAUD, T.V.N.; TORCHIA, Mark G. Embriologia clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. 602 p.

17. Homem de 60 anos apresenta tosse, perda de peso e cansaço há 4 meses. Tabagista por 40 anos. Radiografia de tórax revelou massa de 10 cm no pulmão esquerdo, cuja biópsia demonstrou carcinoma de células escamosas de pulmão. Qual dos seguintes carcinógenos está envolvido na patogênese do câncer de pulmão deste paciente?
- A. Aflatoxina B1.
 - B. Fenobarbital sódico.
 - C. Hidrocarbonetos aromáticos.
 - D. Asbestos.

Alternativa Correta: (C) A carcinogênese do fumo ocorre com a combustão do tabaco, originando os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Trata-se de um cancerígeno indireto por precisar ser metabolizado para exercer seus efeitos. É uma das substâncias carcinogênicas mais estudadas. As demais alternativas se referem a carcinógenos hepáticos, ou de outros tipos de neoplasias.

Bibliografia: Robbins and Cotran. *Pathologic Basis of Disease*, 10^ª. Ed., Elsevier, Philadelphia, 2020.; Franco M, Montenegro M. *Patologia Processos Gerias*, 6^ª Ed., Atheneu, São Paulo, 2015.

18. Loxosceles é o gênero a qual pertence a aranha marrom, uma aranha pequena, de hábitos noturnos. A maioria dos acidentes notificados se concentra nos estados do sul, particularmente no Paraná e Santa Catarina. Seu veneno é um dos mais ativos sobre o organismo humano. Uma única picada pode determinar a morte de uma criança ou mesmo de um adulto. A peçonha da Loxosceles é do tipo proteolítico e hemolítico, produzindo sintomatologia:
- A. cutânea e renal.
 - B. cutânea e cardíaca.
 - C. renal e neurológica.
 - D. cardíaca e neurológica.

Alternativa Correta:

(A) A peçonha da Loxosceles é do tipo proteolítico e hemolítico, produzindo sintomatologia cutânea e renal. Dores intensas logo após o acidente são pouco frequentes, mas costumam tomar-se muito fortes, as vezes lancinantes, depois de algumas horas, ou no decorrer do primeiro dia. Febre, náuseas, vômitos e, às vezes, diarreia, são relatados. A aplicação do soro nas primeiras 14 a 24 horas após o acidente previne a hemoglobinúria e as lesões renais.

Bibliografia: NEVES, D. P. e cols. *Parasitologia Humana*. 13^ª ed. Editora Atheneu, 2016.

19. Mulher de 35 anos, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. Desde o AVC, ela tem tido dificuldades em planejar e organizar tarefas, além de apresentar dificuldade em controlar suas emoções e comportamentos. Qual lobo cerebral foi afetado no AVC desta paciente?
- A. Occipital esquerdo.
 - B. Frontal esquerdo.
 - C. Temporal direito.
 - D. Parietal direito.

Alternativa Correta: (B) O lobo frontal é responsável pelo planejamento, organização e controle de comportamentos e emoções. O AVC da paciente afetou o lobo frontal esquerdo, resultando em dificuldades em planejar e organizar tarefas, bem como em controlar suas emoções e comportamentos. As outras opções estão incorretas porque esses lobos cerebrais não estão diretamente relacionados às funções cognitivas afetadas por um AVC no lobo frontal esquerdo. O lobo occipital esquerdo é responsável pela percepção visual e reconhecimento de objetos (opção O lobo temporal direito está mais associado à memória de longo prazo e ao reconhecimento de rostos. O lobo parietal direito é mais associado à percepção sensorial e ao processamento de linguagem.

Bibliografia: BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W.; PARADISO, Michael A. *Neurociências: desvendando o sistema nervoso*. Artmed editora, 2017.

20. Em quadros hemorrágicos graves, as respostas fisiológicas compensatórias deverão incluir:
- A. diminuição da adrenalina circulante e aumento do hormônio antidiurético.
 - B. dedução do débito cardíaco e aumento da adrenalina circulante.
 - C. aumento do hormônio antidiurético e diminuição da resistência dos leitos vasculares cutâneos.
 - D. aumento da resistência dos leitos vasculares cutâneos e aumento da frequência cardíaca.

Alternativa Correta: **(D)** Em quadros hemorrágicos graves, as respostas fisiológicas compensatórias do organismo visam manter a perfusão adequada dos órgãos vitais e evitar a falência múltipla de órgãos. Algumas das respostas fisiológicas incluem: aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição, aumento da frequência respiratória e liberação de hormônios como adrenalina. Essas respostas fisiológicas são mecanismos de compensação para evitar a hipoperfusão dos órgãos vitais em situações de hemorragia grave.

Bibliografia: JAMESON, J. Larry. Medicina Interna de Harrison - 2 Volumes. 20. Porto Alegre, RS: McGraw-Hill, 2020.

Pediatria

21. O crescimento e desenvolvimento de um recém-nascido passam por várias etapas importantes. Qual das seguintes afirmações melhor descreve uma característica do desenvolvimento motor durante o primeiro ano de vida?

A. O controle cefálico é adquirido aos quatro meses.
B. O bebê começa a andar com apoio até os oito meses.
C. A criança começa a sentar sem apoio entre seis e nove meses.
D. O controle das mãos ocorre antes do controle cefálico.

Alternativa Correta: **(C)** O controle cefálico é adquirido antes, por volta dos dois meses. A maioria das crianças começa a andar com apoio entre nove e doze meses. O controle das mãos ocorre após o controle cefálico, em torno dos quatro meses. A criança normalmente começa a sentar sem apoio entre seis e nove meses.

Bibliografia: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de pediatria. 6. ed. Barueri: Manole, 2024. 2 v. 3400 p.

22. Com base nas características semiológicas do recém-nascido prematuro, assinale a alternativa correta.

A. Apresenta pele lisa, vernix caseoso, hipotonia, genitália masculina com bolsa escrotal lisa, reflexos diminuídos.
B. Apresenta pele espessa, hipotonia, genitália feminina com lábios menores protrusos, reflexos aumentados.
C. Apresenta pele translúcida, vernix caseoso, hipertonia, genitália masculina com bolsa escrotal rugosa, reflexos aumentados.
D. Apresenta pele lisa, hipertonia, genitália feminina com lábios menores protrusos, reflexos diminuídos.

Alternativa Correta: **(A)** O prematuro tem características peculiares em decorrência do grau de sua imaturidade, apresentando-se com pele fina e lisa, recoberta por vernix caseoso, tecido adiposo escasso, musculatura pouco desenvolvida, presença de edema nas primeiras horas de vida, tônus muscular e reflexos diminuídos. A cabeça é relativamente grande quando comparada ao tórax, com fontanelas amplas. Glândula mamária bem diminuída ou não palpável, tórax depressível. Abdome globoso, genitália feminina com lábios menores protrusos, genitália masculina com bolsa escrotal mais lisa, sem definição de rafe mediana, testículos geralmente não palpáveis.

Bibliografia: PEDIATRIA, Sociedade Brasileira de. Tratado de pediatria. 6. ed. Barueri: Manole, 2024.

23. Menina de 2 anos, é levada à emergência com história de crise convulsiva generalizada tônico-clônica há pouco mais de uma hora. O episódio durou cerca de cinco minutos e apresentou resolução espontânea. Há dois dias iniciou com tosse e coriza hialina, além disso, tem febre há aproximadamente 12 horas. Encontra-se em bom estado geral, sinais vitais estáveis e sem alterações neurológicas ao exame. Tem tio materno com epilepsia. Sobre o caso clínico é correto afirmar que a paciente apresentou uma crise convulsiva:

A. febril complexa e há necessidade de realizar investigação complementar com líquido e imagem do sistema.
B. febril simples e não há necessidade de realizar investigação complementar neste momento, assim como, não há necessidade de medicação profilática das crises.
C. de etiologia a esclarecer e há necessidade de realização de eletroencefalograma para diagnóstico diferencial de epilepsia hereditária.
D. de etiologia a esclarecer e há necessidade de realização de eletroencefalograma, tomografia de crânio e líquido para diagnóstico diferencial de epilepsia hereditária.

Alternativa Correta: **(B)** Convulsão febril é um evento que ocorre na primeira infância, geralmente entre 3 meses e 5 anos de idade, associado a febre, mas sem evidência de infecção intracraniana ou causa definida para convulsão. Em geral ocorrem pela rápida elevação da temperatura, a maior parte nas primeiras 24h do início da febre. As crises podem ser classificadas como simples, àquelas generalizadas e de curta duração, habitualmente não ocorrem mais de uma vez em 24 horas e se resolvem espontaneamente ou complexas, que são crises mais prolongadas, têm sintomas focais e podem recorrer dentro de 24h ou na

mesma doença febril. Geralmente não é indicado a realização de exames complementares em crianças maiores de 6 meses, que estejam em bom estado geral e que não apresentem sinais meníngeos, ou sinais de depressão do sistema nervoso central. O tratamento das crises convulsivas febris é de suporte, se durarem menos de 15 minutos e geralmente não é indicado terapia de manutenção com anticonvulsivante.

Bibliografia: Tratado de Pediatra da Sociedade Brasileira de Pediatria, Volume 2, 6ª Edição, 2025.

24. Menino seis anos de idade, após queda de bicicleta, evoluiu com secreção purulenta na lesão de cotovelo. Sua mãe conta que após oito dias, a criança começou a 'ficar inchada' e apresentava urina de cor avermelhada. Na emergência pediátrica, verificou que a criança apresentava hipertensão, conforme referência, para sua estatura e sexo. Sobre o quadro renal que provavelmente acometeu o paciente, é possível afirmar que:

- A. existe alteração dos níveis de triglicerídeos.
- B. é mais frequente no sexo feminino.
- C. a restrição hídrica e de sódio não faz parte do tratamento.
- D. o nível da fração C3 do complemento está diminuído.

Alternativa Correta: **(D)** A glomerulonefrite pós-estreptocócica trata-se de uma sequela tardia, não supurativa, de infecção estreptococcia prévia em vias aéreas superiores ou infecções de pele causadas por cepas nefritogênicas de estreptococo beta hemolítico do grupo A de Lancefield e outros agentes infecciosos. Sua manifestação clínica é composta pela tríade edema, hipertensão e hematúria de instalação súbita e sua fisiopatologia se relaciona ao depósito de imunocomplexos nos glomérulos com consumo da fração C3 do complemento.

Bibliografia: Silva LR, Solé D, Silva CAA, Constantino CF, Liberal EF, Lopez FA. Tratado de Pediatria. Sociedade Brasileira de Pediatria. 5ª Ed. Editora Manole, 2022.

25. A aferição da pressão arterial (PA) em crianças segue recomendações específicas para garantir uma medida precisa. Sobre a aferição da PA em crianças, assinale a alternativa correta.

- A. O tamanho do manguito a ser utilizado deve ser escolhido com base na faixa etária da criança, pois há tamanhos padronizados para cada idade.
- B. A pressão arterial deve ser aferida preferencialmente no braço esquerdo, pois oferece valores mais fidedignos e evita subestimação da pressão arterial.
- C. A pressão arterial deve ser medida em todas as crianças, independentemente da idade, em todas as consultas médicas.
- D. Crianças maiores de 3 anos devem ter a PA aferidas pelo menos uma vez ao ano e as menores de 3 anos apenas em condições clínicas específicas.

Alternativa Correta: **(D)** Todas as crianças a partir dos 3 anos devem ter a pressão arterial aferida ao menos uma vez ao ano. Em crianças menores de 3 anos, a aferição da PA não é rotina, mas deve ser realizada na presença de condições especiais, como prematuridade extrema, doenças renais, cardiopatias congênitas, histórico de infecção do trato urinário recorrente, entre outras. A aferição da PA não é obrigatória em todas as consultas para todas as crianças, mas sim anualmente a partir dos 3 anos ou em casos específicos. A escolha do manguito não é baseada na faixa etária, mas sim na circunferência do braço da criança, garantindo medidas mais precisas. A PA deve ser aferida preferencialmente no braço direito, pois isso permite comparação com tabelas padronizadas e evita leituras falsamente baixas no caso de coarctação da aorta.

Bibliografia: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Hipertensão arterial na infância e adolescência. Manual de Orientação do Departamento Científico de Nefrologia, n. 2, abr. 2019.

26. Menina com 7 anos de idade, apresenta desenvolvimento das mamas (telarca) e crescimento acelerado nos últimos meses. O exame físico confirma estágio II de Tanner e ausência de sinais de virilização. A história clínica revela obesidade desde os 4 anos de idade, e os exames laboratoriais mostram níveis elevados de leptina e insulina. Com base nesse caso, qual é o mecanismo fisiopatológico mais provável relacionado à obesidade e ao desenvolvimento da puberdade precoce?

- A. A obesidade eleva os níveis de insulina, que amplifica a secreção de gonadotrofinas pela hipófise e aumenta a sensibilidade ovariana ao FSH, desencadeando a puberdade precoce.
- B. A obesidade aumenta os níveis de leptina, que age no hipotálamo estimulando a liberação precoce de GnRH, iniciando a ativação do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal e o desenvolvimento puberal.
- C. A obesidade promove aromatização periférica de andrógenos em estrogênios no tecido adiposo, que age diretamente no tecido mamário e no crescimento ósseo sem ativação do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal.
- D. A obesidade reduz a síntese de SHBG (globulina ligadora de hormônios sexuais), aumentando a fração livre de estrogênios, o que acelera o crescimento puberal sem ativação do eixo hipotalâmico-hipofisário.

Alternativa Correta: **(B)** A obesidade aumenta os níveis de leptina, que age no hipotálamo estimulando a liberação precoce de GnRH, iniciando a ativação do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal e o desenvolvimento puberal, pois a leptina desempenha papel central na regulação da puberdade e sua elevação em crianças obesas pode antecipar o início do desenvolvimento puberal. A insulina tem um papel mais associado à sensibilização ovariana do que à ativação do eixo hipotalâmico. A aromatização periférica, pode causar telarca precoce isolada, mas sem ativação do eixo HPG. A redução da SHBG aumenta a fração livre de estrogênios, mas não é o principal mecanismo de início da puberdade.

Bibliografia: PEDIATRIA, Sociedade Brasileira de. Tratado de pediatria. 6. ed. Barueri: Manole, 2024.

27. Uma menina de 7 anos apresenta crises asmáticas frequentes, necessitando de uso de beta-agonistas de curta duração mais de quatro vezes por semana, além de apresentar despertares noturnos ocasionais. Seu exame clínico está normal fora das crises. O médico decide ajustar o plano terapêutico. Marque a medida recomendada como primeira escolha para o controle do caso a longo prazo.

- A. Uso contínuo de beta-agonistas de curta duração (salbutamol).
- B. Administração de corticosteroide oral por 7 dias.
- C. Introdução de corticoide inalatório em dose baixa diária.**
- D. Uso diário de anti-histamínico para controle de alergias associadas.

Alternativa Correta: **(C)** A terapia de manutenção com corticoide inalatório é o tratamento de primeira linha em asma persistente leve. O uso contínuo de beta-agonistas não é adequado por aumentar o risco de efeitos adversos e piora do controle. Corticoides orais são reservados para crises graves, e anti-histamínicos não controlam a inflamação das vias aéreas associada à asma.

Bibliografia: GINA (Global Initiative for Asthma), 2023.

28. Uma mãe de um recém-nascido de 5 dias chega à UBS relatando dor intensa durante as mamadas e fissuras mamilares. Ela menciona que o bebê parece estar sugando com frequência, mas não consegue manter a pega por muito tempo e frequentemente solta o seio chorando. Ao observar a amamentação, nota-se que o bebê está abocanhando apenas o mamilo, sem incluir a aréola. Qual das seguintes orientações é a mais adequada para corrigir a pega e resolver o problema relatado?
- A. Orientar a mãe a massagear a mama antes das mamadas para facilitar a saída do leite e reduzir a dor durante a sucção.
 - B. Explicar que a dor é normal nos primeiros dias de amamentação e que a apoiadura, após o sétimo dia, resolverá o problema.
 - C. Ensinar a mãe a posicionar o bebê de forma que ele abocanhe a aréola e o mamilo, com a boca bem aberta e o lábio inferior virado para fora.
 - D. Sugerir a alternância entre amamentação e mamadeira, pois isso pode ajudar o bebê a sugar melhor e reduzir a dor da mãe.

Alternativa Correta: (C) A dor durante a amamentação e as fissuras mamilares são frequentemente causadas por uma pega inadequada, que, no caso descrito, envolve o bebê apenas abocanhar o mamilo e não a aréola. Ensinar a mãe a posicionar corretamente o bebê, de forma que ele consiga abocanhar a aréola e o mamilo com a boca bem aberta e o lábio inferior virado para fora, é fundamental para corrigir a pega e resolver o problema relatado. A massagem antes da amamentação, pode ajudar na produção de leite, mas não resolve a causa subjacente da dor. A alternativa que afirma que a dor é normal, ignora a possibilidade de correção da pega. A alternância entre amamentação e mamadeira, pode prejudicar ainda mais a pega, além de interferir na amamentação exclusiva, recomendada para os primeiros meses de vida.

Bibliografia: PEDIATRIA, Sociedade Brasileira de. Tratado de pediatria. 6. ed. Barueri: Manole, 2024. E-book. p.286. ISBN 9788520458679.

29. Um lactente de 6 meses é levado ao pronto-socorro com história de 3 dias de coriza, tosse e febre baixa (37,8°C). Hoje, os pais notaram que ele está com dificuldade para respirar, apresentando chiado e taquipneia (frequência respiratória de 60 rpm). Ao exame físico, observa-se tiragem subcostal, batimento de asa de nariz e ausculta pulmonar com sibilos bilaterais e roncospersos. A saturação de oxigênio é de 92% em ar ambiente. Qual é a hipótese diagnóstica e a conduta inicial adequada?
- A. Infecção de vias aéreas superiores; conduta com medidas de suporte, como hidratação e lavagem nasal, e orientação sobre sinais de alerta.
 - B. Bronquiolite viral; conduta com suporte respiratório (oxigênio se necessário), hidratação e monitorização contínua.
 - C. Pneumonia bacteriana; conduta com antibioticoterapia parenteral e suplementação de oxigênio para manter saturação acima de 95%.
 - D. Asma; conduta com broncodilatadores inalatórios e corticoide oral para controle da inflamação das vias aéreas.

Alternativa Correta: (B) O quadro clínico descrito, com histórico de coriza, tosse, febre baixa, dificuldade respiratória, chiado, taquipneia, tiragem subcostal e sibilos bilaterais, é característico de bronquiolite viral, uma infecção comum em lactentes, geralmente causada por vírus respiratórios, como o vírus sincicial respiratório (VSR). A conduta inicial envolve suporte respiratório, como administração de oxigênio quando necessário, hidratação e monitorização contínua do quadro clínico. A infecção de vias aéreas superiores geralmente não causa dificuldade respiratória significativa e sinais de taquipneia ou tiragem. A pneumonia bacteriana, pode ser descartada pela ausência de sinais típicos de pneumonia, como dor torácica ou crepitações. A asma geralmente não se manifesta em lactentes dessa maneira, e o quadro é mais sugestivo de uma infecção viral.

Bibliografia: PEDIATRIA, Sociedade Brasileira de. Tratado de pediatria. 6. ed. Barueri: Manole, 2024. E-book. p.286. ISBN 9788520458679.

30. Qual das seguintes afirmações é correta sobre a assistência médica na Parada Cardiorrespiratória (PCR) em crianças?
- A. A PCR em crianças deve ser tratada com a sequência A-B-C (Airway, Breathing, Circulation) como na reanimação adulta.
 - B. Durante a PCR em crianças, a ventilação deve ser realizada a cada 6 segundos (10 respirações por minuto) para garantir eficácia.
 - C. Na PCR pediátrica, a sequência recomendada é C-A-B (Circulation, Airway, Breathing), com ênfase nas compressões torácicas.
 - D. A PCR em crianças não requer o uso de desfibrilador externo automático (DEA), pois os ritmos cardíacos são geralmente não chocáveis.

Alternativa Correta: **(C)** Na PCR pediátrica, a sequência recomendada é C-A-B (Circulation, Airway, Breathing), com ênfase nas compressões torácicas. Isso se deve ao fato de que a principal causa de PCR em crianças é a hipóxia, e a prioridade é restaurar a circulação sanguínea eficaz através de compressões torácicas de alta qualidade. A ventilação é importante, mas vem em segundo lugar na sequência.

Bibliografia: Medway. (2023). Parada cardiorrespiratória em pediatria - destrinchando o PALS/SAVP.; American Heart Association. (2020). Novas recomendações para parada cardiorrespiratória (RCP) em Pediatria.; VEGA, Roy M.; KAUR, Hersimran; EDEMEKONG, Peter F. Cardiopulmonary Arrest In Children. 2021.

31. Uma criança de 12 meses é levada ao pronto-socorro com história de 4 dias de diarreia aquosa, vômitos e irritabilidade. A mãe relata que a criança está com redução da diurese, recusa alimentar e apresenta fezes explosivas com muco. Ela também menciona que a criança começou a usar fórmula à base de leite de vaca há 2 semanas. Ao exame físico, observam-se mucosas secas, enchimento capilar lento (3 segundos), turgor cutâneo diminuído e abdômen distendido. A criança está sonolenta, mas responsiva. A frequência cardíaca é de 150 bpm, e a frequência respiratória é de 35 rpm. Qual é a hipótese diagnóstica e a conduta imediata?
- A. Diarreia por *Escherichia coli* enteropatogênica; conduta com antibioticoterapia oral e hidratação venosa para correção da desidratação.
 - B. Diarreia viral por adenovírus; conduta com hidratação venosa imediata e internação para monitorização da desidratação grave.
 - C. Alergia à Proteína do Leite de Vaca; conduta com suspensão da fórmula láctea, hidratação venosa e introdução de fórmula extensamente hidrolisada.
 - D. Giardíase; conduta com antiparasitário oral, hidratação oral e orientação sobre medidas de higiene para evitar a transmissão familiar.

Alternativa Correta: **(B)** A criança apresenta sinais de desidratação grave, como mucosas secas, enchimento capilar lento e turgor cutâneo diminuído. Além disso, os sintomas gastrointestinais, como diarreia aquosa, vômitos e fezes explosivas com muco, são comuns em infecções virais, como a diarreia viral por adenovírus. O histórico de diarreia aquosa prolongada, com vômitos e irritabilidade, é consistente com infecções virais, que geralmente apresentam esses sintomas em lactentes. A desidratação grave e o estado sonolento e responsivo podem justificar a necessidade de hidratação venosa e internação para monitorização.

Bibliografia: PEDIATRIA, Sociedade Brasileira de. Tratado de pediatria. 6. ed. Barueri: Manole, 2024. E-book. p.286. ISBN 9788520458679.

32. Lactente de seis meses apresenta há três dias febre de 39°C, redução das mamadas ao peito e diminuição da diurese. Exame físico: criança chorosa, sem outras alterações. Exames laboratoriais: Hemograma: Hb 11.5g/dl; Ht 33%; leucócitos 24.000/mm³ com desvio à esquerda e neutrófilos com granulações tóxicas; plaquetas 200.000/mm³. Proteína C reativa: 8 mg/dl (VR = até 0,5 mg/dl). Urina tipo 1 (coleta por cateterismo vesical): leucócitos 380.000/ml. Após a coleta de exames foi iniciada antibioticoterapia intravenosa. A febre cessou em 24 horas e o antibiótico foi passado para via oral no terceiro dia de internação. A urocultura revelou mais de 1.000.000 UFC/mL de *Escherichia coli*. A criança teve alta no quarto dia de internação, com orientação para completar 7 dias de antibioticoterapia oral. Qual exame deve ser solicitado ambulatorialmente após o tratamento para investigação de complicações?
- A. Ultrassonografia de rins e vias urinárias.
 - B. Urografia excretora.
 - C. Cintilografia renal dinâmica (DTPA).
 - D. Uretrocistografia pós-miccional.

Alternativa Correta: **(A)** O objetivo da investigação por imagem é descartar malformações do trato urinário que possam implicar em piores desfechos no futuro. O ultrassom de rins e vias urinárias é o exame de avaliação morfológica inicial, especialmente em menores de 2 anos com pielonefrite.

Bibliografia: Brasil. Tratado de pediatria / organização Sociedade Brasileira de Pediatria. ? 5. Ed. ? Barueri - SP: Manole, 2022.

33. Paciente de 6 anos, há dois dias iniciou quadro de obstrução nasal moderada, espirros, rinorreia hialina, leve dor na faringe, febre de 38,2°C. A história pregressa da criança é negativa para sintomas nasais crônicos. Uma rinoscopia anterior apresenta mucosa nasal hiperemiada e a oroscopia sugere faringe e amígdalas hiperemiadas. Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica.
- A. Faringite estreptocócica.

- B. Rinite alérgica.
- C. Rinossinusite aguda bacteriana.
- D. Resfriado comum.**

Alternativa Correta: **(D)** O resfriado comum apresenta uma grande variedade de manifestações e pode ser acompanhado de febre ou de mal-estar. A mucosa respiratória se encontra hiperemiada, e a pessoa acometida pode apresentar dor de garganta, rouquidão e tosse. Na faringite estreptocócica a febre é alta, acompanhada de exsudato purulento e adenomegalia jugular em 60% dos casos. Na Rinite Aguda tem história pregressa a sintomas pós exposição a alérgenos, hipertrofia e palidez de cornetos. A Rinossinusite Aguda Bacteriana aparece com piora dos sintomas do resfriado comum após o 5º dia, secreção purulenta na rinofaringe e dor intensa local, geralmente unilateral.

Bibliografia: Pechebea MD, Vita WP. Otite média, sinusite e tonsilite agudas. In: Sociedade Brasileira de Pediatria; Simon Junior H, Pascolat G, organizadores. PROEMPED Programa de Atualização em Emergência Pediátrica: Ciclo 2. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2018. p. 55?103. (Sistema de Educação Continuada a Distância, v. 2).; Godinho RN, Ibiapina CC, Ganem CMA. Infecções das vias aéreas superiores, rinites e rinossinusites. In: Sociedade Brasileira de Pediatria; Leone C, Cabral SA, organizadores. PROPED Programa de Atualização em Terapêutica Pediátrica: Ciclo 5. Porto Alegre: Artmed Panamericana; 2018. p. 51?71. (Sistema de Educação Continuada a Distância, v. 1).

34. O crescimento do perímetro cefálico no período pós-natal reflete processos essenciais do desenvolvimento cerebral. Qual das seguintes alternativas melhor explica esse crescimento?
- A. O crescimento é influenciado predominantemente por sinaptogênese e mielinização, com impacto limitado da neurogênese após o nascimento.**
 - B. O perímetro cefálico reduzido ao nascimento tem fisiopatogenia fortemente associada a defeitos de migração neuronal.
 - C. O perímetro cefálico atinge seu valor máximo ao final do primeiro ano de vida, sem crescimento significativo após esse período.
 - D. A retificação do perímetro cefálico ao longo do primeiro ano de vida deve alertar para craniossinostose.

Alternativa Correta: **(A)** O crescimento pós natal ocorre principalmente por sinaptogênese e mielinização, visto que a neurogênese usualmente tem impacto máximo até 18-20 semanas gestacionais, com pouco ou quase nenhuma proliferação após esse período. A fisiologia do crescimento cerebral intrauterina é diretamente associada a neurogênese cerebral. Os defeitos de migração podem ser associados, mas isoladamente não justificam alteração de perímetro cefálico. Embora o crescimento do perímetro cefálico seja mais acelerado nos primeiros anos de vida, ele não atinge seu valor máximo ao final do primeiro ano. O crescimento continua, ainda que em um ritmo mais lento, ao longo da infância e até a adolescência. A retificação do perímetro cefálico indica patologias neurais predominantemente a doenças ósseas. Usualmente a craniossinostose cursa com manutenção de perímetro cefálico e assimetria craniana

Bibliografia: RODRIGUES, Marcelo Masruha. Tratado de Neurologia Infantil. São Paulo: Atheneu, 2021.; Klieman RM, St. Geme JW. Nelson de Pediatria. 21 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2020.

35. O diagnóstico diferencial de afecções psiquiátricas na infância e adolescência pode ser desafiador devido à sobreposição de sintomas e à influência de fatores do desenvolvimento. Considerando o caso de uma criança de 8 anos com dificuldades de interação social, comportamentos repetitivos e atraso na linguagem. Qual das seguintes condições é mais comumente associada ao diagnóstico diferencial do Transtorno do Espectro Autista (TEA)?
- A. Transtorno de Ansiedade Social (Fobia Social).
 - B. Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) com prejuízo funcional grave.
 - C. Transtorno de Comunicação Social (Pragmático).
 - D. Transtorno de Aprendizagem Específico com prejuízo na leitura.**

Alternativa Correta: **(D)** Transtorno de Ansiedade Social pode apresentar dificuldades de interação social, mas não comportamentos repetitivos ou atraso na linguagem; TOC grave pode envolver comportamentos repetitivos, mas geralmente não está associado a atrasos na linguagem ou prejuízos na interação social típicos do TEA; Transtorno de Comunicação Social pode ser confundido com TEA, pois ambos envolvem prejuízos na comunicação social, mas o TEA inclui também comportamentos repetitivos e interesses restritos.

Bibliografia: American Psychiatric Association (APA). (2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).; Kliegman, R. M., et al. (2020). Nelson Textbook of Pediatrics. Elsevier.; Brasil. Ministério da Saúde. (2015). Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA).

36. Em um plantão de pronto atendimento chega uma menina de 3 anos de idade com histórico de diarreia e vômitos há 24h, sendo 3 episódios de vômitos e 5 episódios de diarreia. A mãe refere que ofereceu apenas água e chá, que a criança bebeu avidamente, refere também redução do volume urinário nas últimas 12 horas. Após exame clínico completo foi diagnosticada com desidratação grave e iniciada expansão volêmica com soro fisiológico endovenoso, inicialmente com boa resposta, porém ao final da expansão percebe-se no monitor cardíaco o achatamento das ondas 'T' e o surgimento das ondas 'U', além do "alargamento" do intervalo QT. Baseado nesses dados, qual o distúrbio hidroeletrólítico que a paciente está apresentando?

- A. Hipocalemia.
- B. Hipercalemia.
- C. Hipocalcemia.
- D. Hipercalemia

Alternativa Correta: (A) A diarreia aguda é uma doença típica na infância e ainda hoje importante causa de morbimortalidade infantil em países em desenvolvimento, sendo ainda um importante problema de saúde pública. As perdas gastrointestinais volumosas estão entre as causas mais comuns de hipocalemia, principalmente em crianças que não receberam soro de reidratação oral, preconizado pela OMS (cuja concentração de K é de 20mmol/L). Dentre os sinais clínicos as alterações de condução cardíaca podem ser evidenciadas no eletrocardiograma pode aparecer o achatamento ou inversão das ondas 'T' e o surgimento das ondas 'U', que podem ser notadas pelo o alongamento do intervalo QT.

Bibliografia: Dias, DGM; Oliveira, LEG, Oliveira, DLC. A importância do Soro de Reidratação Oral (SRO) na diarreia aguda em pré-escolares. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 7, n. 9, p. 01-23, nov./dec., 2024.; Franca Melo, EJ; Pereira Franca, RC. MANEJO DA DESIDRATAÇÃO NA CRIANÇA. Brazilian Journal of Surgery & Clinical Research, 2024, Vol 46, Issue 1, p35.; Gomes, EB; Pereira. HCP. Distúrbios do Potássio. Vittalle ? Revista de Ciências da Saúde v. 33, n. 1 (2021) 232-250).

37. Lesões intracranianas são achados clínicos que podem ocorrer em pacientes expostos a Toxoplasmose Congênita. Qual é a lesão que sugere esta correlação clínica?

- A. Edema cerebral.
- B. Hidrocefalia.
- C. Calcificações intracranianas difusas.
- D. Empiema do sistema nervoso central.

Alternativa Correta: (C) Calcificações intracranianas ocorrem de forma recorrente em Lesões por Toxoplasmose e Citomegalovírus. As primeiras têm aspecto mais difuso, enquanto que as por Citomegalovírus tem localização intraventricular.

Bibliografia: Nelson textbook of pediatrics, 20th edition. Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria, 4ª edição, Barueri, SP: Manole, 2017.

38. Menina de 10 anos, foi a consulta na Unidade de Pronto Atendimento por dor abdominal, náuseas e vômitos há 24 horas. Familiar refere que a menina vem apresentando muita sede há cerca de 3 meses, com piora hoje. Refere aumento do volume urinário e redução do apetite com perda de peso há 2 meses. Nega outros sintomas. Dados vitais: temperatura 37,0 °C, frequência cardíaca: 120 bpm, frequência respiratória: 22 ipm, saturação de oxigênio: 96%, PA 110x70 mmHg, glicemia capilar de 420 mg/dl. Assinale a alternativa que corresponde aos parâmetros de gasometria e glicemia esperados nesse caso clínico.

- A. pH menor do que 7,20, bicarbonato maior do que 15mEq/L, glicemia acima de 150mg/dl.
- B. pH menor do que 7,30, bicarbonato menor do que 15 mEq/L, glicemia acima de 200 mg/dl.
- C. pH maior do que 7,45, bicarbonato maior do que 20mEq/L, glicemia abaixo de 200mg/dl.
- D. pH menor do que 7,20, bicarbonato menor do que 20 mEq/L, glicemia abaixo de 150mg/dl.

Alternativa Correta: (B) O provável diagnóstico da paciente em questão é o de diabetes mellitus devido aos sintomas de hiperglicemia, dor abdominal, poliúria, polidipsia, anorexia e perda de peso associada a descompensação por cetoacidose diabética caso apresente acidose metabólica com pH menor do que 7,30 e bicarbonato menor do que 15 mEq/L, glicemia acima de 200 mg/dl e presença de cetonemia e cetonúria. Neste caso, deverá ser internada e receber tratamento com expansão volêmica e, após cerca de 2 horas, a infusão de insulina regular por via endovenosa, juntamente com soro de manutenção

Bibliografia: Sociedade Brasileira de Pediatria. Tratado de Pediatria. 5ª. Ed., Manole, São Paulo, 2022.

39. Menina de 14 anos com agitação, tremores, insônia e perda de peso há 40 dias, apesar da ingesta alimentar estar normal. Exame físico: BEG, corada, hidratada, eupneica, afebril. FC: 124 bpm, FR: 16 ipm, PA: 136x84 mmHg. Pele quente e úmida, com tremor fino em extremidades, com olhar assustado. Palpação de bócio difuso, doloroso à palpação, de consistência fibroelástica. BCRNF sem sopros. Exame pulmonar e de abdome inocentes. Pulsos presentes e simétricos. Qual a principal hipótese diagnóstica?
- A. Câncer de tireoide.
 - B. Tireoidite de Hashimoto.
 - C. Bócio endêmico.
 - D. Doença de Graves.

Alternativa Correta: (D) A questão discorre sobre as possíveis causas de distúrbios da tireoide. Exige que o aluno saiba diferenciar hipotireoidismo de tireotoxicose e a partir disso assinalar a doença que se encaixa na descrição do quadro clínico. A doença de Graves é a causa mais comum de hipertireoidismo na infância. Os sintomas são de agitação, dificuldade de concentração, bócio (em 98% dos casos), irritabilidade, sudorese, taquicardia, diarreia, emagrecimento, aumento do apetite, sono agitado, dispneia, intolerância ao calor, labilidade emocional, mãos úmidas e quentes e tremores finos de extremidades. A oftalmopatia infiltrativa (exoftalmia) ocorre em 50% dos casos de doença de Graves na infância. Geralmente, os nódulos e os cânceres de tireoide são assintomáticos. A presença de sintomas dependerá do tamanho e da localização da lesão. Geralmente, na criança com neoplasia se observa a presença de um nódulo de tireoide, que é palpado usualmente se for maior que 1,5 cm. Outras vezes a neoplasia ao diagnóstico pode se apresentar com linfonodomegalia isolada e/ou com aumento do volume tireoidiano. A tireoidite de Hashimoto pode cursar inicialmente com quadro de hipertireoidismo em 10% dos pacientes em razão da destruição de folículos e da liberação dos hormônios tireoidianos na corrente sanguínea e, posteriormente, evolui com hipotireoidismo transitório ou definitivo por causa da destruição glandular. Não cursa com proptose palpebral. O bócio endêmico é causado por falta de ingesta de iodo em áreas carentes e causa hipotireoidismo. Algumas pessoas que ingerem excesso de iodo, em especial aquelas anteriormente deficientes, desenvolvem hipertireoidismo (fenômeno de Jod-Basedow). Paradoxalmente, o excesso de consumo de iodo pela tireoide pode inibir a síntese de hormônio tireoideo (o chamado efeito Wolff-Chaikoff). Dessa maneira, a toxicidade de iodo pode causar bócio por iodo, hipotireoidismo ou mixedema. Quantidades muito grandes de iodo podem causar paladar metálico, salivação aumentada, irritação gastrointestinal e lesões acneiformes na pele.

Bibliografia: 1- *Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria / [organizadores Dennis Alexander Rabelo Burns... [et al.]].* Págs. 675-680 - 4. ed. - Barueri, SP: Manole, 2017 2- *Documento científico - Departamento de Endocrinologia ? SBP Nº 17, Jun 2022.*

40. O calendário atual de vacinação do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda que as três primeiras doses da vacina poliomielite, seja realizada com a vacina poliomielite 1, 2 e 3 inativada (VIP), aos dois, quatro e seis meses de idade. Qual seria a razão para a não indicação da vacina poliomielite atenuada 1 e 3 (VOP) em crianças que não tenham recebido as três doses de VIP, especialmente em crianças hospitalizadas e imunodeficientes?
- A. A vacina oral poliomielite (VOP) com vírus atenuado pode causar poliomielite associada ao vírus da vacina.
 - B. Está contra-indicado devido a vacina oral poliomielite (VOP) disponível atualmente conter apenas o poliovírus 1 e 3.
 - C. A duração da imunidade conferida pela vacina oral poliomielite 1 e 3 é muito curta.
 - D. A vacina oral poliomielite 1 e 3 é inativada pelo leite materno.

Alternativa Correta: (A) De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria as três primeiras doses, aos 2, 4 e 6 meses, devem ser feitas obrigatoriamente com a vacina pólio inativada (VIP). A recomendação para as doses subsequentes é que sejam feitas preferencialmente também com a vacina inativada (VIP). Nesta fase de transição da vacina pólio oral atenuada (VOP) para a vacina pólio inativada (VIP) é aceitável o esquema atual recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) que oferece três doses iniciais de VIP (2, 4 e 6 meses de idade) seguidas de duas doses de VOP (15 meses e 4 anos de idade). Desde 2016 a vacina VOP é bivalente, contendo os tipos 1 e 3 do poliovírus, podendo ser utilizada nas doses de reforço ou nas Campanhas Nacionais de Vacinação. Deve-se contraindicar VOP para crianças imunocomprometidas e para seus contatos domiciliares. Nestas circunstâncias utilizar a VIP. A Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda que, idealmente, todas as doses sejam com a VIP. Não utilizar VOP em crianças que não tenham ainda recebido as 3 doses de VIP, hospitalizadas e imunodeficientes. Tanto a VIP quanto a VOP, em seus esquemas recomendados, são altamente imunogênicas e eficazes na prevenção da poliomielite. A administração de VIP resulta em soroconversão em 95% ou mais dos receptores da vacina para cada um dos 3 sorotipos após 2 doses e resulta em soroconversão em 99% a 100% dos receptores após 3 doses. A imunidade provavelmente dura toda a vida. Após a exposição a poliovírus vivos, a maioria das crianças imunizadas com VIP excreta o vírus nas fezes, mas não na orofaringe. A imunização com 3 ou mais doses de VOP induz excelentes respostas de anticorpos séricos e substancial imunidade intestinal contra reinfecção por poliovírus. Uma série de 3 doses de VOP, como anteriormente usado nos Estados Unidos, resulta em imunidade sustentada, provavelmente vitalícia.

Bibliografia: ? Ministério da Saúde. *Calendário Nacional de Vacinação.* Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao/calendario-vacinal-2022/anexo-calendario-de-vacinacao-da-crianca->

Saúde Coletiva

41. Mulher de 32 anos, procura Unidade Básica de Saúde com queixa de tontura, dor de cabeça, cansaço e náuseas. Trabalha diariamente em uma horta comunitária, onde um colega de trabalho apresenta sintomas semelhantes. A conduta será:
- A. realizar notificação de intoxicação crônica por hidrocarboneto e afastar do trabalho.
 - B. solicitar exames complementares, afastar a paciente e investigar condições de trabalho e produtos utilizados.
 - C. solicitar dosagem de eletrólitos, prescrever hidratação endovenosa e medidas para tratamento de insolação.
 - D. receitar sintomáticos, afastar a paciente e encaminhar ao neurologista.

Alternativa Correta: (B) A paciente possui um quadro agudo (ao menos o que se entende pela leitura não é de uma história de longa data), havendo total nexo causal com o ambiente ocupacional (em virtude de outra pessoa da mesma atividade laboral desenvolver clínica semelhante). Dessa forma, pautados, pelo regimento de monitoramento da exposição ocupacional por meio da Norma Regulamentadora - NR-7, contida na Portaria SSST nº 24, de 29 de dezembro de 1994, é imprescindível afastamento do paciente com investigação por meio de exames complementares (laboratoriais, imagem, entre outros), além de investigar minuciosamente as condições de trabalho, incluindo produtos utilizados no cenário atual de trabalho, para buscar informações relevantes dentro da ceara do nexo causal com patologia e ambiente ocupacional.

Bibliografia: DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R.J. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 1952 p. ISBN 9788536326184 (enc.); CAMPOS, Gastão Wagner de Souza et al. (org.). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec; 2012. 871 p. (Saúde em debate, 170). ISBN 9788527107044 (broch.).

42. Em uma UBS, um médico atende a um paciente que apresenta sintomas de uma doença em seu quadro inicial, pouco diferenciado, portanto, sem algumas das características que julga necessárias para ter certeza diagnóstica. Diante da situação, o médico acredita que um exame laboratorial possa auxiliá-lo. Nesse caso pode-se esperar que, em relação a um teste solicitado:
- A. se for um teste sensível, em caso de resultado positivo, o médico saberá que é pouco provável que o paciente não seja portador da doença.
 - B. se for um teste específico, e o resultado vier negativo, o médico poderá afirmar que o paciente não é portador da doença.
 - C. a probabilidade de um resultado falso positivo do teste aumentará quanto maior a prevalência da doença em questão.
 - D. o valor preditivo do teste dependerá da prevalência da doença em questão.

Alternativa Correta: (D) Um teste sensível pode trazer a ocorrência de falsos negativos. Um teste específico não descarta a hipótese com um resultado negativo. Quanto mais prevalente a doença, maior a chance de um resultado positivo representá-la.

Bibliografia: Lotufo PA, Benseñor IM, Olmos RD. Epidemiologia clínica. In: Gusso G et al. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação e prática. 2a ed. Porto Alegre: Artmed; 2019. Cap. 26. p. 213-225.

43. Evidências embasam que a espiritualidade impacta aspectos da promoção da saúde e bem-estar biopsicossocial. Nesse sentido, é importante que os profissionais estejam atentos a abordagem do aspecto espiritual das pessoas que atendem, pois:
- A. apesar de a literatura descrever associação entre espiritualidade com menor prevalência de depressão e ansiedade, ainda inexistem estratégias terapêuticas que a utilizem.
 - B. o limite entre espiritualidade e religiosidade é tênue, estando o primeiro conceito relacionado a uma dimensão formal de ligação a uma instituição e, o segundo, a um aspecto dinâmico e extrínseco, que independem de instituição religiosa.
 - C. a abordagem da espiritualidade afasta a prática profissional do método clínico centrado na pessoa, pois muitos profissionais ainda observam conflitos na abordagem do tema.
 - D. a compreensão da espiritualidade tem papel inclusivo no tocante à diversidade sociocultural e permite salientar a vivência pessoal do ser humano nos processos saúde/doença.

Alternativa Correta: **(D)** Muitos autores desenvolveram, instrumentos para a abordagem da espiritualidade na prática clínica, sendo utilizadas no âmbito da APS: FICA, HOPE; Spiritual History. A religiosidade está ligada a um conceito mais tradicional relacionado a uma instituição e um sistema organizado de práticas e simbolismos, ao passo que a espiritualidade tem caráter universal e intrínseco, não necessariamente ligado a instituições religiosas. Abordar a religiosidade é um dos caminhos para aplicar o método clínico centrado na pessoa, uma vez que está intimamente ligada à experiência pessoal dos entendimentos de saúde/doença.

Bibliografia: Filho EDC, Oliveira JAC, Schwalm FD. Espiritualidade e saúde. In: Gusso G et al. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação e prática. 2a ed. Porto Alegre: Artmed; 2019. Cap. 95. p. 807-815.

44. O diagnóstico de dengue é feito a partir de dados clínicos e epidemiológicos. Para reforçá-los, é possível lançar mão de testes específicos e inespecíficos, sobre os quais podemos afirmar que:
- A. o hemograma, coagulograma, provas de função hepática e dosagem de albumina sérica são exames inespecíficos, nos quais se espera encontrar leucocitose com neutrofilia.
 - B. até o 5º dia de doença o vírus está presente e para identificá-lo pode-se utilizar: isolamento viral, PCR ou pesquisa do antígeno NS1.
 - C. o hemograma não apresenta alterações de base importantes antes das primeiras 48h, não sendo útil como linha de base para o acompanhamento do paciente.
 - D. a pesquisa de anticorpos imunoglobulina M (IgM) é o exame preferencial em amostras coletadas até o 7º dia de doença.

Alternativa Correta: **(B)** IGM pode ser utilizado até 30º dia da doença; As alterações mais comuns incluem leucopenia, neutropenia, linfócitos atípicos, plaquetopenia e hemoconcentração. O hemograma é a linha de base para o acompanhamento do paciente e melhor se coletado precocemente para identificação posterior de alterações.

Bibliografia: Batista SR, Melchior F, Martinez CH, Marques SM. Dengue, Chikungunya e Zika. In: Gusso G et al. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação e prática. 2a ed. Porto Alegre: Artmed; 2019. Cap. 257. p. 2214-2226.

45. O médico está em um Pronto Atendimento e recebe um paciente de 38 anos com queixa de emagrecimento de 7kg nos últimos 60 dias, dificuldade para deglutir e cefaleia holocraniana com piora progressiva há 10 dias que no momento o impede de dormir. O paciente nega uso de medicamentos contínuos. Durante o exame físico observa-se adenomegalias cervicais, dermatite seborreica e monilíase no palato mole. Qual o diagnóstico provável da cefaleia?
- A. Neuralgia do trigêmeo.
 - B. Neurocriptococose.
 - C. Enxaqueca.
 - D. Hemorragia subaracnóidea.

Alternativa Correta: **(C)** Paciente com quadro clínico muito sugestivo de imunodeficiência com infecções oportunistas, sendo os sintomas apresentados sugestivos de neurocriptococose. Importante o médico saber reconhecer no pronto atendimento um caso suspeito de AIDS para evitar atraso no diagnóstico.

Bibliografia: Ministério da Saúde, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção do Hiv Em Adultos, Módulo II. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

46. Adolescente de 16 anos comparece a uma Unidade de Saúde da Família relatando que há 13 horas teve relações sexuais com outro rapaz da mesma idade que conheceu em um aplicativo de relacionamento, ele está preocupado porque não utilizaram preservativo durante a relação e ele não consegue contato com o parceiro. Qual a conduta recomendada, considerando a política de prevenção combinada ao HIV?
- A. Por ser menor de idade o médico deve orientar os agentes comunitários de saúde a convocar os pais ou responsáveis para acompanhar a consulta.
 - B. Realizar os testes rápidos e caso o teste venha não reagente, liberar o menor com recomendação de repetir o teste em 30 dias, sem a profilaxia, porque ela não está indicada em menores de idade.
 - C. Entrar em contato com o conselho tutelar para acompanhar o caso e tomar as medidas judiciais cabíveis.
 - D. Realizar os testes rápidos para IST e caso o teste para HIV seja não reagente, iniciar profilaxia pós exposição com antirretrovirais.

Alternativa Correta: **(D)** A profilaxia pós exposição deve ser iniciada em até 72h da exposição no caso de não se conhecer o status sorológico da fonte.

Bibliografia: Ministério da Saúde, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de Risco à Infecção pelo HIV, IST e Hepatites Virais. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

47. De acordo com as atribuições previstas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecida pela Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, qual das opções abaixo representa uma atribuição exclusiva do médico na Atenção Básica, distinguindo-se das atribuições dos demais membros da equipe?

- A. Colaborar no mapeamento do território da equipe, identificando famílias e indivíduos em situações de risco.
- B. Avaliar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar e acompanhar o paciente durante o tratamento.**
- C. Prestar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde controlados que possuem algum grau de dependência.
- D. Auxiliar no gerenciamento de insumos necessários para o funcionamento adequado da Unidade Básica de Saúde.

Alternativa Correta: **(B)** A avaliação da necessidade de internação hospitalar ou domiciliar e o acompanhamento do paciente são atribuições exclusivas do médico na Atenção Básica, conforme descrito na PNAB. Essa responsabilidade distingue-se das funções dos demais membros da equipe, que podem prestar cuidados em domicílio ou gerenciar insumos, mas não têm competência para decidir sobre a internação.

Bibliografia: BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 68, 22 set. 2017.

48. Considerada uma doença infecciosa, de notificação compulsória e passível de cura, é endêmica em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, com destaque para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Sua transmissão ocorre pelo contato direto pessoa a pessoa, facilitada pelo convívio de doentes não tratados com indivíduos susceptíveis. Acomete nervos periféricos e a pele, também a mucosa do trato respiratório superior, olhos, linfonodos, entre outros. Que doença é essa?

- A. Hanseníase.**
- B. Sífilis.
- C. Dengue.
- D. Tuberculose.

Alternativa Correta: **(A)** A hanseníase é uma doença infecciosa e contagiosa que afeta a pele e os nervos. É também conhecida como lepra ou mal de Lázaro. Os sintomas apresentados são de hanseníase. Sintomas: Manchas esbranquiçadas, amarronzadas ou acastanhadas na pele; Alteração da sensibilidade térmica, dolorosa, tátil e força muscular; Caroços e placas em qualquer local do corpo; Diminuição da força muscular. A transmissão se dá por meio de gotículas de saliva eliminadas na fala, tosse e espirro em contatos próximos e frequentes com doentes que ainda não iniciaram tratamento.

Bibliografia: Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. ? Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 152 p.: il.

49. A interprofissionalidade na atenção primária a saúde (APS) é essencial para o enfrentamento das Doenças e Agravos não Transmissíveis (DANT). A atuação conjunta de médicos, enfermeiros, nutricionistas, profissionais de educação física e outros profissionais permite uma abordagem integral do cuidado. Qual das ações a seguir melhor exemplifica o trabalho interprofissional na APS para o manejo das DANT?

- A. Os profissionais da APS realizam reuniões periódicas para construção de planos terapêuticos singulares, com foco em estratégias de promoção da saúde e prevenção das complicações.**
- B. A equipe de saúde realiza encontros interprofissionais para discussão de casos complexos, priorizando assistência individual para acompanhamento das DANT.
- C. O enfermeiro e o médico atuam de forma conjunta na prescrição e no acompanhamento dos pacientes com DANT, sendo os demais profissionais acionados apenas se houver necessidade.
- D. A UBS prioriza a distribuição de medicamentos para pacientes com doenças crônicas, pois mudanças no estilo de vida são de responsabilidade individual.

Alternativa Correta: **(A)** A interprofissionalidade na APS fortalece o cuidado integral e contínuo, promovendo a construção de planos terapêuticos singulares (PTS) de forma coletiva. Essa abordagem melhora o manejo das DANT, garantindo ações de promoção da saúde, prevenção de complicações e adesão ao tratamento. Segundo Peduzzi (2019), a interprofissionalidade é fundamental para um cuidado colaborativo, articulando diferentes saberes para atender às necessidades dos usuários.

Bibliografia: PEDUZZI, M. Interprofissionalidade e Práticas Colaborativas em Saúde: Conceitos e Aplicações. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 23, 2019.

50. As tendências temporais e a transição epidemiológica são conceitos fundamentais para a análise da evolução dos padrões de doenças e agravos à saúde ao longo do tempo. A transição epidemiológica descreve mudanças nos perfis de morbimortalidade, influenciadas por fatores sociais, econômicos e tecnológicos. Assinale a alternativa correta.
- A. Em países que passaram por um processo avançado de transição epidemiológica, observa-se o predomínio de doenças crônico-degenerativas, enquanto as doenças infecciosas e nutricionais deixam de ser relevantes para a saúde pública.
 - B. A transição epidemiológica ocorre de forma linear e irreversível, levando à substituição completa das doenças infecciosas por doenças crônicas, sem coexistência entre esses perfis de morbimortalidade.
 - C. A transição epidemiológica ocorre de maneira uniforme em todas as populações, sendo determinada exclusivamente pelo desenvolvimento econômico, sem influência de fatores culturais, ambientais e comportamentais.
 - D. As tendências temporais de doenças e agravos à saúde podem ser analisadas por meio de séries históricas, permitindo identificar padrões cíclicos, tendências ascendentes ou descendentes e impactos de intervenções em saúde.**

Alternativa Correta: **(D)** Embora as doenças crônicas predominem em países desenvolvidos, as doenças infecciosas ainda representam desafios, como infecções hospitalares, pandemias e doenças emergentes; A transição epidemiológica não é linear nem irreversível. Em muitos países, há recrudescência de doenças infecciosas devido a surtos epidêmicos, resistência microbiana e desigualdades sociais; A transição epidemiológica não ocorre de maneira uniforme em todas as populações. Além do desenvolvimento econômico, fatores como cultura, hábitos alimentares, políticas de saúde e mudanças climáticas influenciam esse processo.

Bibliografia: ? Brasil. Ministério da Saúde. Vigilância em Saúde e Análise de Tendências Epidemiológicas. Brasília: MS, 2022. Barreto, M. L. O conceito de transição epidemiológica. Revista Brasileira de Epidemiologia. 2020;23:e200002.

51. Em uma unidade de saúde da família, para identificar possíveis casos de diabetes mellitus, a equipe resolveu realizar exame de glicemia capilar em todos os pacientes hipertensos cadastrados em sua área de abrangência. Este tipo de ação é de prevenção:
- A. Primária, pois tem o objetivo de fazer diagnóstico precoce de diabetes, antes mesmo de o paciente apresentar sintomas.
 - B. Secundária e não deve ser realizada nesse caso, pois gera um custo desnecessário para o sistema de saúde.
 - C. Primária e deveria ser realizada em todos os pacientes cadastrados na unidade, independentemente de fatores de risco.
 - D. Secundária e justifica-se pelo elevado custo do diabetes e suas complicações para o paciente e o sistema de saúde.**

Alternativa Correta: **(D)** Prevenção primária se faz no período pré-patogênico, portanto antes do aparecimento da doença clínica. Inclui a promoção de saúde e a proteção específica. Prevenção secundária é realizada no indivíduo já sob a ação do agente patogênico e inclui o diagnóstico precoce, como no caso acima, tratamento precoce, e limitação das complicações. A DM não insulino-dependente é geralmente assintomática nas fases iniciais, e apresenta diversas complicações clínicas, geralmente com custo para a sociedade bastante elevado.

Bibliografia: Rouquayrol MZ & Almeida Filho N. Epidemiologia e Saúde. 5ª. Ed., Medsi, Rio de Janeiro, 1999. DUNCAN B., SCHIMIDT M.I., GIULIANI E.R.J. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseada em Evidências. 3. ed. Artmed: Porto Alegre, 2004.

52. Segundo o modelo de Leavell & Clark, qual dos seguintes é um exemplo de prevenção terciária?
- A. A realização de exames de rastreamento para detecção precoce de câncer.
 - B. A promoção de hábitos saudáveis para prevenir doenças cardiovasculares.
 - C. O tratamento de um paciente com diabetes mellitus para evitar complicações.**
 - D. A vacinação para evitar a ocorrência de doenças infecciosas.

Alternativa Correta: (C) O tratamento de diabetes mellitus para evitar complicações é um exemplo de prevenção terciária, que se foca em minimizar os danos de doenças já instaladas. O rastreamento é uma forma de prevenção secundária, pois visa detectar doenças precocemente. A promoção de hábitos saudáveis é prevenção primária, focada em evitar que doenças ocorram. A vacinação é uma forma de prevenção primária, voltada para evitar a infecção.

Bibliografia: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento: caderno de atenção primária nº 29. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

53. Um ensaio clínico randomizado avaliou a eficácia de uma nova vacina contra o vírus Influenza em adultos com idade superior a 60 anos. Foram randomizados 2.000 participantes, sendo 1.000 no grupo que recebeu a vacina e 1.000 no grupo que recebeu placebo. Durante o período de acompanhamento de 12 meses, observou-se que 50 participantes do grupo vacinado desenvolveram a doença, enquanto no grupo placebo houve 150 casos. O risco relativo (RR) foi calculado como 0,33, com intervalo de confiança (IC) de 95% igual a 0,25-0,43. Com base nesses dados, a interpretação correta do RR e de seu intervalo de confiança é:
- A. a vacina reduziu o risco de infecção pelo vírus Influenza em 67%, mas a precisão estatística é baixa, pois o intervalo de confiança não inclui o valor 1.
 - B. A vacina aumentou o risco de infecção pelo vírus Influenza em 33%, sendo essa associação estatisticamente significativa.
 - C. A vacina reduziu significativamente o risco de infecção pelo vírus Influenza em 67%, com alta precisão estatística, uma vez que o intervalo de confiança não inclui o valor 1.
 - D. A vacina aumentou o risco de infecção pelo vírus Influenza em 33%, mas sem relevância estatística, uma vez que o intervalo de confiança não inclui o valor 1.

Alternativa Correta: (C) O risco relativo de 0,33 indica que o risco no grupo vacinado foi 67% menor do que no grupo placebo (eficácia da vacina). Eficácia = $(1 - RR) \times 100$. Além disso, o intervalo de confiança (0,25-0,43) está totalmente abaixo de 1, confirmando a significância estatística da associação. Embora o valor de 67% indique redução do risco, a afirmação de baixa precisão estatística é equivocada, pois o intervalo de confiança não inclui o valor 1. O RR menor que 1 indica redução, e não aumento, do risco no grupo vacinado em comparação ao grupo placebo. O RR menor que 1 demonstra redução do risco, e a afirmação de que o intervalo de confiança não inclui o valor 1 é incorreta, uma vez que o intervalo está entre 0,25 e 0,43.

Bibliografia: ALENCAR NETO, José Nunes de (Org). Manual de Medicina Baseada em Evidências. 1. Ed. Salvador, Ba: Editora Sanar, 2021.; HULLEY, Stephen B. et al. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem epidemiológica - 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

54. Mulher de 25 anos, compareceu à Unidade Básica de Saúde para realizar a primeira consulta de pré-natal. Ela está em união estável há cerca de oito anos e esta é a primeira gestação da paciente. Não apresenta comorbidades e nega medicações de uso contínuo. Como parte da rotina, foi realizado teste rápido para sífilis, que apresentou resultado reagente. Indique a conduta inicial adequada quanto à gestante.
- A. Confirmar o diagnóstico com um segundo teste rápido e aguardar os resultados antes de iniciar o tratamento com Penicilina G Benzatina 2,4 milhões de unidades, intramuscular, dose única.
 - B. Em caso de Teste não-treponêmico (VDRL) com titulação superior a 1:8; iniciar Penicilina G benzatina 2,4 milhões de unidades, intramuscular, semanalmente, em três doses e repetir sorologia após três meses.
 - C. Iniciar tratamento imediato com Penicilina G Benzatina 2,4 milhões de unidades, intramuscular, semanalmente, totalizando três doses.
 - D. Aguardar resultado de Teste não-treponêmico para iniciar o tratamento. Em gestantes, realizar dessensibilização à Penicilina G Benzatina e manter aplicações semanais de 2,4 milhões de unidades, por três semanas.

Alternativa Correta: (C) A sífilis gestacional é uma condição de notificação compulsória e exige manejo imediato para evitar desfechos adversos, como a sífilis congênita. O Ministério da Saúde recomenda que o tratamento com penicilina benzatina seja iniciado imediatamente após um teste rápido reagente, sem necessidade de aguardar confirmação laboratorial adicional. Além disso, o parceiro sexual também deve ser testado e tratado para prevenir reinfecção. Este caso resalta a importância do rastreamento precoce e da intervenção adequada durante o pré-natal para garantir a saúde materno-fetal. A gestante do caso clínico apresenta um quadro de Sífilis Latente Tardia (início indeterminado), portanto, deve iniciar tratamento imediato com Penicilina G Benzatina 2,4 milhões de unidades, intramuscular, 1x/semana, por 3 semanas. Para ser considerado adequadamente tratado, o parceiro de G.B.M também precisa realizar o teste rápido e receber pelo menos uma dose de Penicilina G Benzatina se assintomático.

Bibliografia: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012.; Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Atenção Integral às Pessoas com Infecções

55. Durante uma consulta de rotina na Unidade Básica de Saúde, mulher de 55 anos, sem histórico familiar de câncer de mama, sem comorbidades e assintomática, relata que realizou sua última mamografia há quatro anos. Ela questiona sobre a necessidade de realizar novos exames e compartilha preocupações sobre o risco de câncer de mama. Com base nas recomendações do Ministério da Saúde/INCA, assinale a alternativa com a conduta adequada para esta paciente.
- A. Realizar exame clínico das mamas e solicitar mamografia de rastreamento, uma vez que está fora do intervalo recomendado.
 - B. Realizar exame clínico das mamas e orientar a realização de ultrassonografia mamária devido à idade da paciente.
 - C. Informar que não há necessidade de mamografia, pois a paciente está assintomática, e realizar exame clínico das mamas.
 - D. Solicitar mamografia anual e ultrassonografia mamária, visto que o intervalo superior a dois anos aumenta significativamente o risco de detecção tardia.

Alternativa Correta: (A) Segundo as diretrizes do INCA e do Ministério da Saúde, o rastreamento do câncer de mama é recomendado com mamografia de rastreamento bienal para mulheres assintomáticas entre 50 e 69 anos. A paciente, ao estar fora desse intervalo, deve realizar o exame para readequação ao cronograma de rastreamento. O exame clínico das mamas pode ser realizado como parte do acompanhamento, mas não substitui a mamografia. A ultrassonografia e outros exames não são indicados para rastreamento de rotina, mas apenas como exames complementares em casos específicos, como alterações detectadas na mamografia ou em pacientes com mamas densas. A periodicidade anual ou superior a dois anos não está em consonância com as recomendações vigentes, que equilibram benefícios e riscos.

Bibliografia: Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Controle do Câncer de Mama: Documento de Consenso. Rio de Janeiro: INCA, 2020.; Ministério da Saúde. Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

56. Uma equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) identificou, durante análise situacional do território do qual é responsável, que a maioria dos adultos hipertensos não estava realizando o acompanhamento regular. Diante disso, a equipe elaborou uma proposta de intervenção com a finalidade de integrar ações de promoção, prevenção e cuidado, respeitando os princípios e as diretrizes da Atenção Básica, conforme determina a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Assinale a estratégia que está adequada às diretrizes da PNAB para garantir a integralidade do cuidado frente a esta situação.
- A. Realizar campanhas quadrimestrais de aferição de pressão arterial em espaços públicos, criar grupos de atendimento exclusivos para hipertensos na unidade e ofertar medicamentos para hipertensão.
 - B. Criar uma agenda de consultas prioritárias para hipertensos, desvinculada de ações coletivas de promoção da saúde.
 - C. Implementar a adscrição de clientela, fortalecer o vínculo da equipe da ESF com a população adscrita e realizar o cuidado contínuo por meio de consultas programadas e visitas domiciliares.
 - D. Trabalhar com grupos educativos, com periodicidade semanal, sobre alimentação saudável e atividade física, sem necessidade de ações individuais.

Alternativa Correta: (C) Os princípios e diretrizes da Atenção Básica estabelecidos pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada pela Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017: são Implementar a adscrição de clientela, fortalecer o vínculo da equipe da ESF com a população adscrita e realizar o cuidado contínuo por meio de consultas programadas e visitas domiciliares. A atuação da ESF perante a PNAB está pautada nas diretrizes de: (a) regionalização e hierarquização, (b) territorialização, (c) população adscrita, (d) cuidado centrado na pessoa, (e) resolutividade, (f) longitudinalidade do cuidado, (g) coordenação do cuidado, (h) ordenação da rede e (i) participação da comunidade.

Bibliografia: Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica - PNAB. Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.; Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica. Cadernos de Atenção Básica, n. 37. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

57. O Relatório Dawson, publicado em 1920, foi o marco da ideia de Atenção Primária à Saúde como forma de organização dos sistemas nacionais de saúde. Sobre este relatório e seu impacto, assinale a alternativa correta.
- A. Introduziu o conceito de territorialização em saúde, sendo que a porta de entrada do sistema de saúde seriam os hospitais-escola, como forma de melhorar a qualidade do ensino médico.
 - B. O relatório não pode mais ser considerado atual, uma vez que os centros primários de saúde devem ser orientados para a comunidade, e os hospitais-escola devem resolver a maior parte dos problemas de saúde da população.

- C. Foi encomendado pelo governo inglês, no intuito de buscar formas de organizar a provisão de serviços de saúde à população de determinada região, garantindo acesso à saúde.
- D. As propostas de mudança trazidas pelo Relatório tinham o objetivo de organizar a provisão dos serviços de saúde, sem necessidade de articulação com sistemas de saúde pública, focadas no atendimento individual dos doentes nos hospitais.

Alternativa Correta: (C) A organização dos serviços de saúde deve estar orientada conforme as necessidades da comunidade, não corresponde ao conceito de territorialização. O conceito de territorialização considera a orientação do serviço de saúde com base nos centros de atenção primária, orientados para a comunidade, regionalizados, não tendo relação com fortalecimento do ensino médico segundo este documento (confusão comum relacionada ao documento "Relatório Flexner"). O relatório ainda é considerado atual, e os centros de atenção primária devem resolver a maior parte dos problemas de saúde da população. As propostas trazidas pelo Relatório apontavam as necessidades de articulação da saúde pública, focando nas necessidades de saúde da comunidade e não em doenças específicas ou grupos de doentes.

Bibliografia: Territorialização. In: GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti; DIAS, Lêda Chaves. *Tratado de Medicina de Família e Comunidade*. Porto Alegre: Editora Artmed, 2019.; PORTELA, Gustavo Zoio. *Atenção Primária à Saúde: um ensaio*. *Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, 27 [2]: 255-276, 2017.

58. Os cuidados paliativos são um conjunto de cuidados à saúde que objetivam melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares, diante de doenças ameaçadoras à vida. A vivência do cuidado paliativo deve ser multidisciplinar, sendo que a Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha um importante papel nesta prestação de cuidados. Compreendendo esta temática, qual a oferta adequada de cuidado paliativo no âmbito da atenção primária?
- A. Gerenciar sintomas, focando no manejo da dor que pode afetar a qualidade de vida dos pacientes.
- B. Envolver pacientes e familiares em conversas abertas e honestas sobre seus valores, necessidades e expectativas, através da comunicação eficaz.
- C. Realizar apoio psicossocial, orientando pacientes e familiares a buscarem suporte emocional no serviço suplementar.
- D. Amparar os cuidados no final da vida, evitando tratar de temas conflitantes religiosos ou espirituais.

Alternativa Correta: (B) Entre as práticas de cuidados paliativos ligados à Atenção Primária, destacam-se o diálogo orientado a pacientes e familiares, gerenciamento de sintomas ? não focados somente a dor, mas os sintomas em geral envolvidos a esta fase da vida, realização de apoio psicossocial no âmbito da APS e em locais de saúde multidisciplinares, amparo nos cuidados de final de vida, facilitando a comunicação sobre temas espirituais que envolvem o processo de adoecimento e morte, e a oferta de horários flexíveis para acolhimento.

Bibliografia: Gusso G. *Tratado de Família e Comunidade*. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2019. Ministério da Saúde. *Cuidados paliativos*.

59. Educação Popular não é o mesmo que "educação informal". Há muitas propostas educativas que se dão fora da escola, mas que utilizam métodos verticais de relação educador-educando (VASCONCELLOS, 2004). Assinale a alternativa que contempla as características da Educação em Saúde na concepção dialogal.
- A. Os educadores/profissionais em saúde e educandos/usuários dos serviços, atuam como iguais, ainda que com papéis diferenciados.
- B. A comunicação tem caráter informativo, na qual os educadores/profissionais em saúde explicitam aos educandos/usuários dos serviços os hábitos saudáveis.
- C. Os movimentos sociais, representantes dos educandos/usuários dos serviços, são alijados por serem expressão da lógica dos setores subalternos da sociedade.
- D. As iniciativas dos educandos/usuários dos serviços são defraudadas por representarem o saber popular.

Alternativa Correta: (A) As características apresentadas nas alternativas erradas se referem à concepção tradicional de educação em saúde, que grosso modo se caracteriza por um estilo de pensamento curativista/biológico, que apresenta uma relação profissional-paciente impositiva. Concepção essa que é criticada pela concepção dialógica.

Bibliografia: Vasconcelos, E. M. (2004). *Educação popular: de uma prática alternativa a uma estratégia de gestão participativa das políticas de saúde*. *Physis: Revista De Saúde Coletiva*, 14(1), 67-83. <https://doi.org/10.1590/S0103-73312004000100005>; 2. Bessen CB, Souza Netto M, Da Ros MA, Silva FW, Silva CG, Pires MF. *A Estratégia Saúde da Família como Objeto de Educação em Saúde*. *Saúde e Sociedade* 2007; 16(1): 57-68.

60. Homem de 45 anos procurou atendimento na Unidade Básica para renovar sua receita de medicamentos anti-hipertensivos. Não apresentava queixas. Ao ser indagado sobre ingestão de álcool, relatou "beber socialmente". O médico assistente aplicou questionário CAGE (instrumento para triagem) e identificou o uso abusivo de álcool. Ao exame apresentava PA 170/90, sem outras particularidades. Na sequência, a abordagem inicial adequada seria:

- A. confirmar o uso regular dos medicamentos e apresentar os possíveis riscos do seu padrão de consumo de álcool.
- B. ajustar a dose do anti-hipertensivo, solicitar um controle da pressão arterial e encaminhar à psicologia.
- C. associar novo anti-hipertensivo e orientar a cessação da ingestão de álcool pelo risco de interação com a medicação.
- D. solicitar controle da pressão arterial com retorno programado e encaminhar para avaliação psiquiátrica.

Alternativa Correta: (A) Avaliar possíveis causas da alteração da pressão arterial é a conduta esperada antes do ajuste de dose ou associação de novo anti-hipertensivo. Dentre as possibilidades terapêuticas na atenção primária à saúde para o uso abusivo de álcool está a intervenção breve, na qual o feedback é o primeiro passo a ser dado. A psiquiatria do NASF oferece apoio matricial e não atendimento ambulatorial individual.

Bibliografia: *Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação e prática/ Organizadores, Gustavo Gusso, José Mauro Ceratti Lopes, Lêda Chaves Dias; [coordenação editorial: Lêda Chaves Dias].-2. Ed.-Porto Alegre: Artmed, 2019.*

Clínica Cirúrgica

61. Um paciente de 54 anos dá entrada no pronto-socorro com dor lombar intensa em flanco direito, febre de 39°C, calafrios, hemograma com 19.970 leucócitos, sendo 4% bastões, creatinina 1,5 ng/ml, PCR 197, PA 100x60 mmHg referindo tontura ao levantar. A tomografia computadorizada revela um cálculo de 8 mm no ureter proximal direito, com hidronefrose associada. Diante do quadro, a conduta inicial mais apropriada será a prescrição de antibiótico e:
- A. realização imediata de ureterolitotripsia extra corpórea para fragmentação do cálculo.
 - B. instalação de duplo J para desobstrução urinária.
 - C. hidratação venosa, aguardando eliminação espontânea do cálculo.
 - D. analgesia por 48 horas antes de qualquer intervenção.

Alternativa Correta: (B) A desobstrução do trato urinário com duplo J ou nefrostomia percutânea é a prioridade no manejo de litíase urinária obstrutiva complicada por sepse, garantindo drenagem adequada da urina antes de qualquer procedimento definitivo para remoção do cálculo.

Bibliografia: Türk C, Neisius A, Petík A, et al. EAU Guidelines on Urolithiasis 2024. European Association of Urology. Disponível em: <https://uroweb.org/guidelines/urolithiasis>.; Assimos D, Krambeck A, Miller NL, et al. Surgical Management of Stones: AUA/Endourology Society Guideline, 2023. The Journal of Urology. DOI: 10.1097/JU.0000000000003187.; Campbell-Walsh Urology, 12th Edition. Wein AJ, Kavoussi LR, Partin AW, Peters CA. Elsevier, 2021.

62. As cirurgias são classificadas quanto ao potencial de contaminação em limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. Qual exemplo abaixo constitui uma cirurgia potencialmente contaminada?
- A. Traqueostomia eletiva em UTI.
 - B. Tratamento de uma hérnia inguinal.
 - C. Tratamento de um aneurisma de carótida.
 - D. Perfuração de ceco por apendicite

Alternativa Correta: (A) Cirurgias potencialmente contaminadas envolvem entrada controlada no trato respiratório, gastrointestinal, geniturinário ou orofaringe sem grande contaminação. A traqueostomia eletiva em UTI, envolve manipulação das vias aéreas, com risco moderado de contaminação.

Bibliografia: SCHWARTZ, S. I. *Princípios de Cirurgia*. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

63. Mulher de 34 anos no quinto dia de pós-operatório de colecistectomia aberta de urgência, chega ao PS com queixa de dor em cicatriz cirúrgica. Dados vitais normais, exceto por temperatura axilar de (37,3o.C). Ao exame, abdome flácido, discretamente doloroso à palpação em hipocôndrio direito e cicatriz apresentando hiperemia, edema e secreção seropurulenta em moderada quantidade e sutura da aponeurose parece estar íntegra. De acordo com os princípios de classificação e manejo de infecções cirúrgicas, podemos afirmar que:
- A. a paciente apresenta infecção de sítio cirúrgico profundo, exigindo reabordagem cirúrgica para debridamento, lavagem ampla da cavidade abdominal e antibioticoterapia endovenosa.
 - B. trata-se de abscesso intra-abdominal; pede-se ultrassom com urgência para avaliação intracavitária, com provável drenagem percutânea guiada por imagem, e antibioticoterapia empírica.
 - C. trata-se de infecção de sítio cirúrgico superficial, e o manejo inicial envolve abertura da ferida, drenagem, curativos diários.

- D. o diagnóstico provável é infecção profunda de ferida operatória, e o tratamento deve ser feito com antibioticoterapia oral e anti-inflamatórios.

Alternativa Correta: (C) Quadro clínico é sugestivo de infecção de sítio cirúrgico superficial, que envolve pele e tecido subcutâneo. O tratamento adequado consiste na abertura da ferida para drenagem da secreção purulenta, seguido de curativos diários. O uso de antibióticos deve ser avaliado e prescrito mediante sinais sistêmicos de infecção, o que não é observado nessa paciente. No entanto a prescrição também não estaria incorreta visto que se deve avaliar outros comensais clínicos e sociais. As outras opções descrevem condições diferentes que exigem abordagens distintas, como abscesso intra-abdominal ou infecção de sítio cirúrgico profunda.

Bibliografia: FAGUNDES, Djalma J.; TAHA, Murched O. *Técnica cirúrgica: princípios e atualizações*. Barueri: Manole, 2023. E-book. p.428. ISBN 9788520464007. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520464007>.

64. Uma criança de 8 anos caiu de bicicleta e apresenta dor no ombro direito, com incapacidade de elevar o braço. O exame físico revela edema, deformidade e crepitação na região da clavícula. Qual é a conduta inicial mais indicada?
- A. Redução incruenta seguida de imobilização com velpeau.
- B. Cirurgia com fixação interna utilizando placa e parafusos.
- C. Imobilização com tipoia e acompanhamento ambulatorial.
- D. Observação clínica sem necessidade de imobilização.

Alternativa Correta: (C) Fraturas de clavícula são comuns em crianças, e normalmente não requerem cirurgia devido ao potencial de cura e remodelação que permite amplitude total de movimento do ombro. Portanto, fratura de clavícula na infância tem abordagem conservadora.

Bibliografia: SIZINIO, Herbert Kanan. *Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática*. 6ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024.

65. Paciente com 55 anos, assintomático, sem medicação de uso regular. Refere na história familiar que seu pai teve câncer de próstata. Apresenta um PSA total de 5,2 ng/ml com exame de urina normal, repetido em 60 dias com aumento para 5,6 ng/ml e exame de urina sem alteração. Ao toque retal apresenta discreto aumento da próstata com consistência fibro elástica e sem nódulos suspeitos. Qual exame seria a melhor opção para o caso?
- A. Cintilografia óssea.
- B. Tomografia computadorizada de pelve.
- C. RNM multiparamétrica da próstata.
- D. Ultrassonografia transretal da próstata.

Alternativa Correta: (C) A RNM é o exame de eleição para identificar áreas suspeitas de neoplasia prostática e orientação para biópsia.

Bibliografia: Panebianco, V., et al. (2015). "Ressonância magnética multiparamétrica da próstata: uma revisão das indicações clínicas e potencial para a prática clínica." **Urologia Europea**, 68(1), 15-23. <https://doi.org/10.1016/j.eururo>.

66. Paciente de 65 anos, tabagista de longa data, diabética tipo 2, com hipertensão arterial sistêmica, é atendida na unidade de Pronto Atendimento com história de dor abdominal de forte intensidade, difusa, com náuseas e alguns episódios de vômitos, além de referir diarreia de aspecto violáceo. Encontra-se taquicárdica, com pulso irregular, com pressão arterial normal, um pouco taquipneica. Após algumas horas de estada na unidade, evoluiu rapidamente com sinais de choque, apresentando acidose metabólica importante, com lactato elevado. Abdome estava flácido, apresentou distensão abdominal, com dor abdominal difusa a palpação. Tomografia de abdome evidencia distensão moderada de grande segmento de jejuno e íleo, com focos de pneumatose intestinal. Acerca do quadro clínico acima, assinale a alternativa correta.
- A. Está indicado arteriografia mesentérica para revascularização mesentérica.
- B. Paciente deve ser levado para centro de terapia intensiva, para suporte hemodinâmico e anticoagulação plena para reversão do quadro abdominal.
- C. Trata-se de um quadro de obstrução intestinal, com presença de diarreia paradoxal, sendo indicado no momento hidratação, sonda nasogástrica e estabilização clínica
- D. Paciente deve ser submetida a cirurgia de emergência para avaliação e ressecção de segmentos de intestino delgado necrosados

Alternativa Correta: **(D)** Os quadros de Isquemia Mesentérica não são raros. Os emergencistas precisam estar aptos para uma avaliação adequado. Devem ter alto índice de suspeição em pacientes idosos, tabagistas, com DM e HAS. Os sintomas simulam uma obstrução intestinal e tem como característica importante a evolução muito rápida para choque. O diagnóstico precoce é fundamental para melhora do resultado do tratamento.

Bibliografia: TOWNSEND, Courtney M. et al. Sabiston Tratado de Cirurgia: A Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna. 21. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2023.; CAMERON, John L.; CAMERON, Andrew M. Current Surgical Therapy. 14. ed. Philadelphia: Elsevier, 2023.; ZINNER, Michael J.; ASHLEY, Stanley W. Maingot's Abdominal Operations. 13. ed. New York: McGraw-Hill, 2019.

67. Um paciente de 68 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica avançada, é internado com quadro de obstrução intestinal secundária a um câncer colorretal. Após avaliação da equipe cirúrgica, é indicado um procedimento de grande porte com riscos elevados de morbimortalidade. O paciente, lúcido e orientado, após ser adequadamente informado sobre seu prognóstico e riscos, recusa a cirurgia, preferindo cuidados paliativos. A família, no entanto, insiste que o procedimento seja realizado, alegando que o paciente não sabe o que está fazendo e que desejam salvar sua vida a qualquer custo. Considerando os princípios da bioética em cirurgia, qual é a conduta mais apropriada da equipe médica?
- A. Convencer o paciente a mudar de opinião, explicando que a cirurgia é a única chance de sobreviver.
 - B. Realizar a cirurgia, pois a preservação da vida é o princípio bioético mais importante.
 - C. Respeitar a decisão do paciente, pois ele está em plena capacidade de autodeterminação e compreende as implicações da sua escolha.
 - D. Solicitar uma avaliação psiquiátrica de rotina para confirmar se o paciente está apto a tomar essa decisão.

Alternativa Correta: **(C)** Respeitar a decisão do paciente, pois ele está em plena capacidade de autodeterminação e compreende as implicações da sua escolha. O princípio da autonomia garante ao paciente o direito de tomar decisões sobre sua própria saúde, incluindo a recusa de tratamentos, desde que esteja em plena capacidade mental e adequadamente informado.

Bibliografia: Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. Principles of Biomedical Ethics. 8ª ed. New York: Oxford University Press, 2019.; Zoboli, E. L. C. P., & Fortes, P. A. C. Bioética Clínica: Reflexões e Casos. São Paulo: Loyola, 2014.; Pellegrino, E. D., & Thomasma, D. C. For the Patient's Good: The Restoration of Beneficence in Health Care. New York: Oxford University Press, 1988.

68. RN inicia com quadro de vômitos em jato, não biliosos, alcalose metabólica e ao exame físico apresenta na palpação abdominal um abaulamento no abdômen superior em forma de azeitona. Este quadro é sugestivo de:
- A. Estenose hipertrófica do piloro.
 - B. Atresia duodenal.
 - C. Refluxo gastro esofágico.
 - D. Atresia de vias biliares.

Alternativa Correta: **(A)** A estenose hipertrófica do piloro é uma condição comum em recém-nascidos, caracterizada por um aumento do músculo pilórico, o que leva a um estreitamento da saída do estômago. Isso causa vômitos em jato, não biliosos, comumente ocorrendo entre 2 a 6 semanas de vida. A criança pode também apresentar alcalose metabólica devido à perda excessiva de ácido gástrico nos vômitos. O exame físico frequentemente revela um abaulamento abdominal em forma de azeitona no quadrante superior direito, que é uma característica clássica dessa condição.

Bibliografia: SCHWARTZ, S. I. Princípios de Cirurgia. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

69. Um paciente de 28 anos chega ao pronto-socorro após sofrer um trauma contuso no olho direito durante uma partida de futebol. Ele relata dor intensa, visão turva e fotofobia. Ao exame físico, observa-se hipema (sangue na câmara anterior), midríase e aumento da pressão intraocular (PIO). Qual é a melhor conduta inicial para o caso?
- A. Cobrir o olho afetado com um protetor ocular rígido e encaminhar urgentemente ao oftalmologista.
 - B. Realizar lavagem ocular imediata com solução salina para remover possíveis detritos.
 - C. Prescrever colírio anestésico tópico para alívio da dor e encaminhar ao oftalmologista em 24 horas.
 - D. Administrar acetazolamida por via oral para reduzir a pressão intraocular e aguardar reavaliação em 6 horas.

Alternativa Correta: (A)

A lavagem ocular não é indicada em casos de hipema, podendo agravar a lesão e aumentar o risco de sangramento; O uso de colírio anestésico tópico é contraindicado em traumas oculares, já que pode mascarar a dor e retardar o diagnóstico de complicações; Embora a acetazolamida possa ser usada para reduzir a PIO, o paciente necessita de avaliação oftalmológica imediata para definir o tratamento adequado.

Bibliografia:- American Academy of Ophthalmology (AAO). (2021). *Basic and Clinical Science Course: Trauma. Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). (2018). Diretrizes para Manejo de Traumatismo Ocular.*

70. Homem de 25 anos apresentou uma queda de moto com lesão isolada em cone medular, os déficits neurológicos encontrados compatíveis com este caso são:

- A. Arreflexia do detrusor com retenção urinária e incontinência por transbordamento, incontinência fecal, impotência, anestesia em sela (S3-S5) e ausência do reflexo anal.
- B. Hiperreflexia do detrusor com incontinência urinária por transbordamento, incontinência fecal, impotência, hiperestesia em sela (S3-S5) e aumento do reflexo anal.
- C. Arreflexia do detrusor com retenção urinária e incontinência por esforço, retenção fecal, anestesia em sela (S1-S4) e ausência do reflexo anal.
- D. Hiperreflexia do detrusor com incontinência urinária por esforço, retenção fecal, impotência, hiperestesia em sela (S1-S4) e aumento do reflexo anal

Alternativa Correta: (A) A lesão do cone medular (localizado em S3-S5) resulta em anestesia em sela, arreflexia do detrusor com retenção urinária e incontinência por transbordamento, incontinência fecal, impotência e ausência do reflexo anal. As demais alternativas apresentam erros, descrevem hiperreflexia e hiperestesia, o que não é característico de lesão do cone medular, que geralmente causa arreflexia e anestesia; menciona retenção fecal e um nível sensorial errado (S1-S4), enquanto a lesão do cone afeta principalmente S3-S5.

Bibliografia: PORTO, C. C. *Semiologia Médica. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.*

71. Depois de três dias com febre, odinofagia e obstrução nasal, mulher de 35 anos, iniciou quadro de trismo e foi palpada linfonodomegalia de 3 cm submandibular à direita. À oroscopia, visualizava-se abaulamento palatal à direita e tonsilas palatinas com placas purulentas. A melhor conduta nesse momento seria:

- A. antibioticoterapia, analgésico e hidratação.
- B. punção e drenagem de abaulamento via cervical.
- C. drenagem via transoral sob anestesia geral.
- D. drenagem via transoral, analgesia e antibioticoterapia.

Alternativa Correta: (D) A paciente tem abscesso com risco de evolução grave caso não seja drenado. É possível a realização do procedimento em sala de procedimentos, sem necessidade de utilização de sala cirúrgica.

Bibliografia: BENTO, R.F. et al. *Otorrinolaringologia Baseada em Sinais e Sintomas. São Paulo: Fundação Otorrinolaringologia, 2011.*

72. Um homem de 58 anos, tabagista e etilista há 30 anos, procura atendimento devido a um nódulo cervical indolor e endurecido, percebido há dois meses. Ele relata disfagia leve, rouquidão persistente e perda de peso não intencional nos últimos três meses. Ao exame físico, observa-se uma massa lateral no pescoço, de aproximadamente 3 cm, fixa e sem sinais flogísticos. A oroscopia revela uma lesão ulcerada na base da língua. Qual a alternativa correta?

- A. O paciente apresenta fatores de risco e sinais sugestivos de neoplasia de cabeça e pescoço, sendo essencial a realização de biópsia da lesão primária e estudo anatomopatológico do linfonodo cervical.
- B. O quadro clínico sugere uma lesão benigna, pois a ausência de dor e sinais inflamatórios indica um cisto branquial, que raramente evolui para malignidade ou metástase.
- C. A principal hipótese diagnóstica é uma linfadenopatia inflamatória inespecífica, devendo ser tratada empiricamente com antibióticos antes da investigação de malignidade.
- D. As neoplasias de cabeça e pescoço geralmente não cursam com rouquidão, disfagia ou perda de peso, sendo esses sintomas mais comuns em doenças benignas do trato respiratório superior.

Alternativa Correta: **(A)** Cistos branquiais são congênitos e geralmente ocorrem em pacientes jovens, podendo apresentar inflamação, mas não estão associados a disfagia, rouquidão e perda de peso; Linfadenopatias inflamatórias geralmente são dolorosas e flutuantes, e não persistentes e endurecidas. Além disso, antibióticos não devem ser administrados antes da investigação de malignidade; Rouquidão, disfagia e perda de peso são sintomas clássicos de neoplasias malignas da região de cabeça e pescoço, principalmente tumores de laringe, orofaringe e hipofaringe.

Bibliografia: Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para Neoplasias de Cabeça e Pescoço. Brasília: MS, 2023.; Cummings Otolaryngology ? Head and Neck Surgery. 7^a ed. Elsevier, 2021.

73. Parte rotineira da cirurgia ambulatorial é a realização da exérese de pequenas lesões cutâneas, sob anestesia local. Após a retirada dessas lesões, realiza-se uma sutura primária da pele com pontos simples separados com fio não absorvível e planeja-se posteriormente a retirada desses pontos. Estes se forem removidos muito tardiamente produzirão marcas e cicatrizes indesejadas e por outro lado, se removidos prematuramente, aumentarão o risco de deiscência da ferida. Assim, sobre o planejamento da retirada dos pontos da pele em suturas com fios não absorvíveis, em pacientes sem comorbidades, assinale a alternativa correta.

- A. Suturas na pele das articulações devem ser removidas em 7 dias.
- B. Suturas na pele da face são comumente removidas depois de 5 dias.**
- C. Suturas na pele do corpo, em geral, devem ser removidas com 14 ou mais dias.
- D. Suturas na pele das mãos e pés devem ser removidas em 7 dias.

Alternativa Correta: **(B)** O período para retirada de pontos cirúrgicos pode variar dependendo da profundidade, extensão da ferida e também das características de cada pessoa como idade, obesidade, diabetes, alimentação adequada ou o uso de medicamentos como quimioterápicos, anti-inflamatórios e corticoides. Rosto e pescoço = 5 dias; Boca e gengiva = 7 dias; mãos e pés = após 14 dias; tronco = 21 dias; pele em geral = 7 a 10 dias. *Bibliografia: TOWNSEND, Courtney M. et al. Sabiston Tratado de Cirurgia: A Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna. 21. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2023.*

74. A ultrassonografia para investigação de dor abdominal em um homem de 47 anos revelou cisto esplênico dominante, com presença de calcificações capsulares e de dois pequenos cistos adjacentes com as mesmas características. Levando-se em conta que a dosagem de anticorpos para *Echinococcus* foi positiva, o tratamento indicado consiste em:

- A. enucleação das lesões.
- B. esplenectomia.**
- C. antibioticoterapia e esvaziamento por punção.
- D. destelhamento da lesão com marsupialização.

Alternativa Correta: **(B)** A esplenectomia é um tratamento indicado para cistos hidáticos no baço, especialmente quando há calcificações e múltiplos cistos, como descrito no caso. A presença de anticorpos para *Echinococcus* sugere infecção por cisto hidático, e a remoção do órgão afetado é uma abordagem eficaz para evitar complicações.

Bibliografia:SBOT. UTIYAMA, Edivaldo; RASSLAN, Samir. Atualização em cirurgia geral, emergência e trauma: cirurgião ano 11. 1. ed. Barueri, SP: Manole, c2020. ISBN 9788520463802.

75. Um paciente de 45 anos, com histórico de hipertensão arterial controlada e obesidade grau II (IMC = 36), será submetido a uma colecistectomia laparoscópica. Durante a indução e manutenção da anestesia o paciente apresenta hipotensão arterial significativa (PA = 75/40 mmHg) após a administração de propofol. Qual é a melhor conduta?

- A. Manter a infusão de propofol e aguardar a estabilização espontânea da pressão arterial.
- B. Suspender imediatamente a infusão de propofol e iniciar fluidoterapia agressiva com cristaloides.
- C. Administrar vasopressina para aumentar a resistência vascular periférica e corrigir a hipotensão.
- D. Reduzir a dose de propofol e administrar pequenas doses de fenilefrina para corrigir a hipotensão.**

Alternativa Correta: **(D)** Suspender abruptamente o propofol pode levar a uma recuperação inadequada da anestesia, e a fluidoterapia agressiva pode não ser suficiente para corrigir a hipotensão rapidamente; A vasopressina não é a primeira escolha para hipotensão aguda pós-indução anestésica, sendo mais utilizada em casos de choque séptico ou refratário; Manter a infusão de propofol sem corrigir a hipotensão pode levar a complicações graves, como hipoperfusão de órgãos vitais.

Bibliografia: 1. Miller, R. D., et al. (2020). Miller's Anesthesia. Elsevier.; Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA). (2020). Diretrizes para Manejo de Hipotensão em Anestesia.

76. No pós-operatório, várias alterações metabólicas e endócrinas ocorrem como resposta ao trauma cirúrgico. Qual das alternativas abaixo explica corretamente a relação entre essas alterações e o equilíbrio hidroeletrólítico?
- A. A liberação de hormônio antidiurético (ADH) aumenta a reabsorção renal de água, resultando em hiponatremia dilucional.
 - B. O aumento de glicocorticoides promove retenção de sódio e água, contribuindo para a manutenção da perfusão tecidual.
 - C. O aumento de catecolaminas reduz a gliconeogênese hepática, causando hipoglicemia no período pós-operatório.
 - D. A secreção de aldosterona reduz a reabsorção de sódio nos túbulos renais, predispondo à hipovolemia

Alternativa Correta: **(B)** Embora os glicocorticoides promovam retenção de sódio e água, o principal mecanismo associado à retenção hídrica no pós-operatório é a liberação de ADH, e não de glicocorticoides. O trauma cirúrgico estimula a liberação de ADH, que aumenta a reabsorção renal de água, levando à diluição do sódio sérico e à hiponatremia dilucional, um achado comum no pós-operatório. O aumento de catecolaminas estimula a gliconeogênese hepática, contribuindo para a hiperglicemia, e não hipoglicemia. A aldosterona aumenta, e não reduz, a reabsorção de sódio nos túbulos renais, o que contribui para retenção de sódio e água, prevenindo hipovolemia.

Bibliografia: Sabiston Tratado de Cirurgia: A Base Biológica da Prática Cirúrgica Moderna, 20ª Edição, 2019.

77. Nos últimos anos com a introdução dos conceitos de cirurgia minimamente invasiva a abordagem cirúrgica de urgência sofreu algumas modificações, porém, as laparotomias ainda possuem suas funções terapêuticas. Sobre as indicações e tipos de laparotomia de urgência é correto afirmar:
- A. As incisões medianas de laparotomias que se localizam na região infraumbilical são as que menos produzem hérnias incisionais.
 - B. As incisões paramedianas e transversas são as mais indicadas pois permitem ampla exploração da cavidade abdominal.
 - C. As laparotomias são as vias de acessos preferenciais para o tratamento das doenças que acometem o abdômen e que demandam uma cirurgia de urgência.
 - D. A instabilidade hemodinâmica com exame clínico abdominal alterado sem outros fatores que explicam o choque é uma indicação de laparotomia.

Alternativa Correta: **(D)** A via de escolha para o tratamento cirúrgico de urgência das doenças abdominais é a laparoscopia, sendo a laparotomia indicada quando existe contraindicação à videocirurgia. A instabilidade hemodinâmica do abdome agudo hemorrágico (choque com alterações no exame físico abdominal sem outra causa aparente) é um dos exemplos de contraindicação da laparoscopia/procedimentos minimamente invasivos. Nas laparotomias de urgência a incisão de escolha é a mediana pois permite uma ampla exploração da cavidade abdominal. As incisões transversas, oblíquas e paramedianas são utilizadas para explorar o sítio cirúrgico adjacentes. As incisões medianas infraumbilicais são as que apresentam a maior taxa de hérnias incisionais pós-operatórias. A violação da aponeurose do oblíquo externo por projétil de arma de fogo é uma indicação de abordagem cirúrgica do abdômen, podendo ser utilizado a laparoscopia ou a laparotomia, dependendo do local atingido e das condições clínicas do indivíduo.

Bibliografia:- Feliciano, Mattox e Moore. Trauma. 9ª Edição. 2020.; Townsend. Sabiston Textbook of Surgery. 20ª Edição. 2016.

78. Homem de 56 anos, com sobrepeso e tabagista, retorna à Unidade Básica de Saúde (UBS) com queixa de astenia e emagrecimento, com 6 meses de evolução e piora progressiva. Traz exames laboratoriais solicitados 2 semanas atrás, mostrando anemia ferropriva e pesquisa de sangue oculto fecal com resultado positivo, questionando a validade dos mesmos, uma vez que nunca percebeu sangramento em suas fezes. Ao exame clínico apresentava-se com mucosas hidratadas e hipocoradas (2+/4+). Frente ao quadro clínico exposto indique a alternativa que representa a principal hipótese diagnóstica com a respectiva conduta.
- A. Deficiência nutricional / solicitar exames de perfil nutricional.
 - B. Neoplasia de cólon direito / solicitar colonoscopia.
 - C. Doença hemorroidária interna / encaminhar ao coloproctologista.
 - D. Doença diverticular / solicitar enema opaco.

Alternativa Correta: **(B)** Neoplasias intestinais do Cólon Direito cursam com anemia ferropriva. O sangramento geralmente não é perceptível por ser anatomicamente distante do canal anal, sendo detectado na forma de Sangue Oculto nas fezes. Paciente acima dos 50 anos, com anemia e PSO + deve fazer colonoscopia.

Bibliografia: Cormann, Textbook of Colon And Rectum Surgery, 2017.

79. Homem de 42 anos foi submetido a gastroplastia Bypass em "Y de Roux" e encontra-se nas primeiras horas após a cirurgia. O time de resposta rápida do hospital é acionado devido a queixas de náuseas, tonturas e episódios de lipotímia ao tentar se levantar. Os dados vitais aferidos demonstram frequência cardíaca de 145 batimentos por minuto, pressão arterial de 80 x 60 mmHg, sudorese e palidez cutânea. Diante do quadro clínico apresentado, qual o diagnóstico e a melhor conduta terapêutica?

- A. Choque hemorrágico e realizar laparoscopia.
- B. Úlcera péptica e realizar endoscopia digestiva alta.
- C. Choque séptico e iniciar antibióticos de amplo espectro
- D. Deiscência de anastomose e iniciar antibióticos de amplo espectro.

Alternativa Correta: (A) Paciente submetido a gastroplastia apresentando sinais de choque hemorrágico no pós-operatório recente e sem sinais de exteriorização de sangramento (enterorragia ou hematêmese). A principal suspeita é de hemorragia intra-abdominal, sendo necessário tratamento cirúrgico devido a instabilidade hemodinâmica.

Bibliografia: Townsend, C.M; Beachamp D; Mattox, K.L - Sabiston TextBook of Surgery: The Biological Basis or Modern Surgical Practice - 21th Ed - Missouri - 2022.

80. De acordo com o *Advanced Trauma Life Support (ATLS)* 10ª Edição (2018), assinale a medida mais adequada para o tratamento de pacientes com queimaduras circunferenciais em membros apresentando síndrome compartimental instalada.

- A. Imobilização com talas.
- B. Administração de sedativos.
- C. Aplicação de compressas frias.
- D. Realização de fasciotomia.

Alternativa Correta: (D) ATLS 10ª edição (2018), Capítulo 8, página 160: O único tratamento para a síndrome compartimental é a fasciotomia. Um atraso na realização de uma fasciotomia pode resultar em mioglobinúria, que pode causar diminuição da função renal.

Bibliografia: ATLS, *Advanced Trauma Life Support*. 10a Ed, 2018.

Clínica Médica

81. Uma paciente de 42 anos, em uso de ácido acetilsalicílico (AAS) 100mg devido a acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico prévio há 8 meses, chega à emergência em janelas (menor que 4,5h) para trombólise. Além disso, a paciente teve um episódio convulsivo antes de chegar ao hospital e apresenta agora pressão arterial (PA) de 210/120 mmHg. Assinale a alternativa que apresente uma contraindicação absoluta à trombólise.

- A. A PA maior que 185/110 mmHg.
- B. O uso de ácido acetilsalicílico (AAS).
- C. O AVC isquêmico prévio.
- D. O episódio de crise convulsiva.

Alternativa Correta: (A) Apenas a alternativa A (PA maior que 185/110 mmHg) apresenta uma contraindicação à trombólise. Relativa pois não foi tentado ainda anti-hipertensivo endovenoso para controle da pressão. O uso de antiagregante plaquetário não aumenta o risco de sangramento. O mesmo em relação à crise convulsiva prévia. O AVC isquêmico prévio contraindicaria se menor que 3 meses da nova trombólise. Como no caso foi há 8 meses, a paciente já pode ser trombolisada novamente. Então as outras alternativas não representam qualquer tipo de contraindicação.

Bibliografia: Berge E, Whiteley W, Audebert H, De Marchis et al. *European Stroke Organisation (ESO) guidelines on intravenous thrombolysis for acute ischaemic stroke*. *Eur Stroke J*. 2021 Mar;6(1):I-LXII. doi: 10.1177/2396987321989865. Epub 2021 Feb 19. PMID: 33817340; PMCID: PMC7995316.

82. Um paciente de 35 anos, com diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior (TDM) há 6 meses, inicia tratamento com um antidepressivo da classe dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS). Após 4 semanas de uso, ele relata melhora parcial dos sintomas depressivos, mas queixa-se de efeitos colaterais significativos, incluindo disfunção sexual, insônia e aumento da ansiedade. O paciente questiona se deve continuar o tratamento. Qual a conduta mais adequada a ser tomada pelo médico?

- A. Suspender o ISRS imediatamente e iniciar um antidepressivo tricíclico (ATC) para evitar efeitos colaterais.
- B. Manter o ISRS e prescrever um ansiolítico para controlar a ansiedade e a insônia do paciente.
- C. Orientar o paciente a persistir com o ISRS por mais 2 semanas, pois os efeitos colaterais podem diminuir.
- D. Suspender o ISRS e encaminhar o paciente para psicoterapia exclusiva, sem uso de medicamentos.

Alternativa Correta: (C) A troca para um antidepressivo tricíclico (ATC) não é a primeira opção devido ao perfil de efeitos colaterais menos favorável. A adição de um ansiolítico pode mascarar os sintomas sem resolver a causa subjacente. A psicoterapia, embora importante, não substitui o tratamento farmacológico em casos de TDM moderado a grave.

Bibliografia: STAHL'S ESSENTIAL PSYCHOPHARMACOLOGY. Prescrição em Psiquiatria. 4^a ed. Artmed, 2021. ; WORLD FEDERATION OF SOCIETIES OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY bb(WFSBP). Guidelines for the Pharmacological Treatment of Depression. 2020.

83. Mulher de 47 anos comparece à consulta com queixa de dor e edema em articulações de mãos, punhos e joelho direito há 5 meses, associada a rigidez matinal de cerca de 3 horas. Tabagista. Nega outras doenças. Ao exame físico apresenta edema das articulações interfalangeanas proximais do 2º e 3º dedos das mãos e da 1ª a 4ª metacarpofalangeanas bilateralmente, edema e calor em punhos e em joelho direito. Exames laboratoriais evidenciam provas inflamatórias elevadas, com VHS: 105mm/h (referência menor que 15mm/h) e PCR: 6mg/dl (referência menor que 0,5mg/dl), além de fator reumatoide negativo. Assinale a alternativa correta.

- A. Deve-se considerar outros diagnósticos diferenciais uma vez que o fator reumatoide negativo exclui a possibilidade de artrite reumatoide.
- B. Trata-se de um caso clínico de osteoartrite generalizada, com quadro atual de agudização, sendo necessário o uso de anti-inflamatório e colágeno.
- C. Paciente preenche critérios para diagnóstico de artrite reumatoide e pode ser tratada inicialmente com corticosteroide e metotrexato.
- D. O quadro é sugestivo de febre reumática, portanto há necessidade de dosagem sérica do anticorpo ASLO e de realização de ecocardiograma

Alternativa Correta: (C) O diagnóstico de artrite reumatóide (AR) pode ser confirmado pelo envolvimento poliarticular, evidência ao exame físico de artrite, duração dos sintomas maior que 6 semanas e provas de atividade inflamatória elevadas. A negatividade do fator reumatoide não exclui o diagnóstico de AR uma vez que sua sensibilidade e especificidade giram em torno de 70-80%. Quadro de poliartrite simétrica crônica com rigidez matinal prolongada não corroboram para a hipótese de osteoartrite, além de que o uso de colágeno não tem mais indicação no tratamento de osteoartrite. Casos de febre reumática são raros após os 30 anos e a poliartrite acomete grandes articulações, com padrão migratório, assimétrico e autolimitado, com duração menor que 4 semanas.

Bibliografia: MOREIRA, CAIO.; SHINJO, Samuel Katsuyuki (ed.). Livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia. 3. Barueri: Manole, 2023.

84. No exame físico de um adulto, ao realizar a inspeção da pele, o médico observa manchas hipocrômicas, arredondadas e discretamente elevadas. Essas alterações podem estar associadas a qual das seguintes condições?

- A. Melanoma.
- B. Dermatite atópica..
- C. Pênfigo vulgar.
- D. Vitiligo.

Alternativa Correta: (C) O vitiligo é caracterizado por manchas hipocrômicas e arredondadas, resultantes de perda de pigmento. O melanoma geralmente apresenta características mais complexas, como assimetria e bordas irregulares. A dermatite atópica é uma condição inflamatória e não está associada a manchas hipocrômicas. O pênfigo vulgar envolve bolhas e erosões, não manchas hipocrômicas.

Bibliografia: TALABARDI, M. Semiologia clínica: fundamentos e aplicações práticas. São Paulo: Editora Medbook, 2017.

85. Mulher de 45 anos comparece à consulta referindo cansaço, sonolência diurna, queda de cabelo, unhas quebradiças e vontade de comer gelo há uns 4 meses. Refere que o fluxo menstrual está irregular, e às vezes vaza na roupa e tem coágulos grandes. Ela acha que deve estar querendo entrar na menopausa. No exame físico apresenta palidez cutâneo-mucosa e está com sinais vitais estáveis. O hemograma mostra hemoglobina de 7,8 g/dL, VCM 68fL, leucócitos e plaquetas normais. Assinale a alternativa que descreve a melhor conduta.

- A. Iniciar ferro oral, encaminhar para o ginecologista e reavaliar a resposta em 2-4 semanas.
- B. Encaminhar para o hospital para transfusão de concentrado de hemácias para melhora rápida dos sintomas e iniciar anticoncepcional oral.
- C. Encaminhar para o hospital e iniciar ferro parenteral devido a gravidade da anemia.
- D. Iniciar ferro oral, ácido fólico, vitamina B12 parenteral e reavaliar em 2-4 semanas

Alternativa Correta: (A) A descrição do caso é típica de anemia ferropriva por sangramento uterino anormal. Nesse caso, diante da estabilidade clínica, a melhor conduta é iniciar a terapia com ferro oral, realizar acompanhamento ambulatorial para reavaliação da resposta e encaminhar ao ginecologista para avaliação do sangramento uterino anormal. Não há justificativa para uso de ácido fólico, vitamina B12, ferro parenteral ou concentrado de hemácias.

Bibliografia: ZAGO, Marco Antonio; FALCÃO, Roberto Passetto; PASQUINI, Ricardo. *Tratado de hematologia*. São Paulo: Atheneu, c2013 xxiii, 899 p. ISBN 978-85-388-0454-3 (enc.); HARRISON, Tinsley Randolph; FAUCI, Anthony S. *Harrison medicina interna*. 17. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2008. 2 v. ISBN 978-85-7726-049-2 (obra completa).

86. O exame físico é um elemento fundamental no diagnóstico médico e deve ser sempre realizado de forma mais apurada possível. Nos casos de meningoencefalite, a irritação meníngea pode ser estudada utilizando-se algumas manobras semiológicas. Dentre elas, o sinal de Brudzinski que é caracterizado da seguinte forma:
- A. o examinador segura a coxa do paciente e flexiona-a sobre o quadril; em seguida estica a perna para cima; o paciente sente dor oferece resistência para flexionar o joelho.
 - B. o examinador eleva a cabeça do paciente, fletindo-a sobre o tronco; como resposta há hiperextensão do joelho e rotação lateral das mãos e dos pés.
 - C. o examinador coloca a mão atrás da cabeça do paciente e a outra no peito e flexiona o pescoço; o sinal é positivo se o paciente flexionar os quadris e os joelhos.
 - D. o examinador eleva o tronco do paciente, fletindo-o sobre a bacia; como resposta o paciente flexiona a perna sobre a coxa e o hiperextende o braço.

Alternativa Correta: (C) De acordo com a etiologia podemos encontrar sinais de irritação meníngea em proporções variáveis nos pacientes com meningoencefalite. O sinal de Brudzinski consiste na flexão involuntária da perna sobre a coxa e desta sobre a bacia, ao se tentar fletir a cabeça do paciente em decúbito dorsal.

Bibliografia: *Semiologia Médica - Celmo Celso Porto - 7ª Edição. 2013. Editora Guanabara Koogan.; Semiologia Médica - Mario López, José Laurentys Medeiros 5ª Edição. 2009. Editora Atheneu.; Semiologia Médica - Celmo Celso Porto - 7ª Edição. 2013. Editora Guanabara Koogan.*

87. A bioética é uma área fundamental para a prática médica, envolvendo questões que orientam o comportamento do profissional em diversas situações com os pacientes. Sobre a bioética na prática médica, assinale a alternativa correta.
- A. O princípio da beneficência se refere à obrigação do médico de não causar dano ao paciente, sendo considerado um dos pilares da ética médica.
 - B. A autonomia do paciente é um princípio que garante ao médico a capacidade de tomar decisões pelo paciente, mesmo sem seu consentimento, quando considerado necessário para o bem-estar.
 - C. O princípio da não-maleficência deve ser ignorado em situações de urgência, quando a ação imediata pode salvar a vida do paciente.
 - D. A justiça em bioética envolve a obrigação do médico de distribuir os recursos de forma equitativa, levando em consideração as necessidades e direitos de todos os pacientes.

Alternativa Correta: (D) A justiça em bioética trata de um princípio que defende a distribuição equitativa dos recursos médicos e o tratamento justo a todos os pacientes. A autonomia do paciente significa que ele tem o direito de tomar decisões informadas sobre seu próprio tratamento, não sendo o médico quem decide unilateralmente. O princípio da beneficência está relacionado ao ato de promover o bem-estar do paciente, não à obrigação de não causar dano, que se refere ao princípio da não-maleficência. O princípio da não-maleficência nunca deve ser ignorado, mesmo em situações de urgência, buscando sempre minimizar os danos.

Bibliografia: Beauchamp, T.L., & Childress, J.F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics* (8th ed.). Oxford University Press.; Gillon, R. (2003). *Ethics, Medicine and Public Health*. Cambridge University Press.; Rachels, J. (2019). *The Elements of Moral Philosophy* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

88. Considerando as orientações atuais sobre tratamento da asma, qual das alternativas abaixo representa a abordagem correta para o manejo de um paciente adulto com asma moderada?

- A. Uso diário de corticosteroide inalatório combinado com um beta-agonista de longa duração, além de um beta-agonista de curta duração como resgate.
- B. Uso exclusivo de beta-agonista de longa duração diariamente, além de um beta-agonista de curta duração como resgate.
- C. Uso intermitente de beta-agonista de longa e curta duração, sem necessidade de corticosteroide inalatório, além de um beta-agonista de curta duração como resgate.
- D. Monoterapia com corticosteroide oral em doses baixas diariamente, além de um beta-agonista de curta duração como resgate.

Alternativa Correta: (A) Os corticosteroides orais são usados em exacerbações agudas ou asma grave não controlada, e não como monoterapia em doses baixas. Uso exclusivo de beta-agonista de curta duração não controla a inflamação subjacente na asma persistente. Uma combinação de beta-agonistas sem corticosteroide inalatório não é suficiente para controle adequado da asma persistente. Esta é a abordagem recomendada para o manejo de asma persistente moderada, maximizando o controle dos sintomas e prevenindo exacerbações.

Bibliografia: Recomendações para o manejo da asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia ? 2020. J Bras Pneumol. 2020;46(1).

89. Rapaz de 19 anos, previamente hígido, procura atendimento com queixa de disfagia progressiva para alimentos sólidos há 6 meses. Relata que, inicialmente, sentia um 'engasgo leve' ao ingerir carnes, mas agora sente que os alimentos ficam presos no meio do peito. Refere episódios intermitentes de impactação alimentar, necessitando beber grandes quantidades de água para engolir. Nega perda de peso significativa, pirose recorrente ou disfagia para líquidos. Não tem comorbidades, mas possui história de asma desde a infância. Com base nesse quadro, qual é o próximo passo mais adequado na investigação?

- A. Solicitar esofagomanometria de alta resolução, pois o quadro sugere um distúrbio motor do esôfago, como acalasia.
- B. Solicitar tomografia de tórax, para descartar tumores de mediastino fazendo compressão externa no esôfago distal.
- C. Solicitar esofagografia baritada, pois é o melhor exame para avaliar estreitamentos esofágicos e estenoses benignas.
- D. Solicitar endoscopia digestiva alta com biopsia esofágica, pois a apresentação clínica sugere esofagite eosinofílica.

Alternativa Correta: (D) O paciente apresenta disfagia progressiva para sólidos, sem perda de peso significativa, com história alérgica, fortemente sugestivo de esofagite eosinofílica (EEO). O exame inicial mais adequado é a endoscopia digestiva alta com biópsias múltiplas, pois a EEO pode ter um aspecto endoscópico normal e o diagnóstico depende da contagem de eosinófilos na mucosa esofágica (maior que 15 eosinófilos/campo de grande aumento). Embora IBPs sejam usados para tratamento da EEO, o diagnóstico precisa ser confirmado antes. A esofagomanometria é útil para distúrbios motores (ex.: acalasia), mas a disfagia progressiva para sólidos sem regurgitação sugere doença estrutural. A esofagografia pode auxiliar na avaliação de estenoses, mas não confirma esofagite eosinofílica. A falta de emagrecimento não sugere tumores de mediastino.

Bibliografia: Schlioma Zaterka-Tratado de Gastroenterologia - Da Graduação à Pós-Graduação, 3ª edição, 2023.

90. Paciente de 60 anos, com histórico de tabagismo e perda de peso não intencional de 5 kg nos últimos três meses, procura atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) com queixa de dor lombar progressiva há três meses. Ele relata que a dor não melhora com o repouso e piora durante a noite. No exame físico, observa-se diminuição da força em membro inferior esquerdo e hiperreflexia. Qual a conduta mais adequada diante desse quadro?

- A. Encaminhar imediatamente para atendimento especializado, por suspeita de doença grave.
- B. Iniciar anti-inflamatório e orientar repouso, com reavaliação em 30 dias.
- C. Iniciar anti-inflamatório e encaminhar para fisioterapia com reavaliação em 60 dias.
- D. Solicitar exames laboratoriais e de imagem para investigação, mantendo acompanhamento ambulatorial na UBS.

Alternativa Correta: (A) Este paciente apresenta sinais de alerta vermelho para dor lombar, incluindo idade acima de 50 anos, perda de peso inexplicada, dor noturna que não melhora com repouso e déficits neurológicos (diminuição de força e hiperreflexia). Esses achados sugerem uma possível causa grave, como neoplasia vertebral ou compressão medular, exigindo avaliação urgente em nível especializado.

PINTO, R.S.; REIS, F.B. Ortopedia e Traumatologia ? Princípios e Prática. 5ª ed. Artmed, 2019.

91. Durante a avaliação de um paciente de 65 anos com histórico de tabagismo intenso, sintomas respiratórios progressivos de dispneia, e tosse produtiva crônica, o médico suspeita de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Qual dos seguintes procedimentos ou resultados diagnósticos é o mais indicativo para confirmar o diagnóstico de DPOC?
- A. Tomografia de tórax demonstrando áreas de enfisema pulmonar e excluindo doenças parenquimatosas.
 - B. Presença de hipoxemia crônica associada a hipercapnia medida por gasometria arterial.
 - C. Relação entre volume expiratório forçado no 1º segundo e a capacidade vital forçada (VEF1/CVF) menor que 70% após uso de broncodilatador.
 - D. Radiografia de tórax mostrando hiperinsuflação pulmonar com aumento dos espaços aéreos e retificação do diafragma na incidência de perfil

Alternativa Correta: (C) Hipoxemia, com ou sem hipercapnia, pode ocorrer em DPOC avançada, mas não é específica para o diagnóstico. A tomografia de tórax é importante para avaliar extensão da doença e associação com doenças parenquimatosas ou mesmo neoplasia de pulmão, mas não é o teste indicado para o diagnóstico de DPOC. O diagnóstico de DPOC é confirmado por espirometria demonstrando VEF1/CVF < 70% após uso de broncodilatador, indicando obstrução irreversível característica da DPOC. Embora radiografias possam mostrar sinais de hiperinsuflação, estas não são diagnósticas por si só para DPOC.

Bibliografia: Doença Pulmonar obstrutiva Crônica - Diagnóstico e tratamento - MANUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE. 1ª edição, 2024. Comissão de DPOC da SBPT.

92. Um paciente de 60 anos apresenta queixas de palpitações, perda de peso e fadiga. Ele também relata aumento da sudorese e intolerância ao calor. O histórico médico inclui hipertensão controlada com losartana e hiperlipidemia tratada com atorvastatina. No exame físico, observa-se um abaulamento cervical anterior difuso junto com sinais de alterações oculares leves, como exoftalmia. Os exames laboratoriais mostram TSH suprimido (menor que 0.01 mU/L) e T4 livre elevado. Assinale a alternativa que indica o diagnóstico mais provável e a intervenção inicial recomendada para controlar rapidamente os sintomas do paciente, respectivamente.
- A. Bócio Multinodular Tóxico; iniciar droga antitireoidiana.
 - B. Hipotireoidismo; iniciar levotiroxina.
 - C. Tireoidite Subaguda; administrar anti-inflamatórios.
 - D. Doença de Graves; iniciar beta bloqueador.

Alternativa Correta: (D) A combinação de sintomas como palpitações, perda de peso, sudorese aumentada e intolerância ao calor, juntamente com o abaulamento cervical anterior difuso e exoftalmia, é indicativa da Doença de Graves. O uso de um beta bloqueador é recomendado para aliviar rapidamente os sintomas adrenérgicos. Embora o bócio multinodular possa causar hipertireoidismo, a presença de exoftalmia e o padrão de abaulamento cervical sugerem mais fortemente a Doença de Graves. Drogas antitireoidianas são uma abordagem para reduzir a produção hormonal no bócio multinodular. A combinação de sintomas como palpitações, perda de peso, sudorese aumentada e intolerância ao calor, juntamente com o abaulamento cervical anterior difuso e exoftalmia, é indicativa da Doença de Graves. O uso de um beta bloqueador é recomendado para aliviar rapidamente os sintomas adrenérgicos. Embora o bócio multinodular possa causar hipertireoidismo, a presença de exoftalmia e o padrão de abaulamento cervical sugerem mais fortemente a Doença de Graves. Drogas antitireoidianas são uma abordagem para reduzir a produção hormonal no bócio multinodular. Hipotireoidismo é geralmente caracterizado por TSH elevado e T4 livre baixo, o oposto dos achados laboratoriais deste paciente. Iniciar levotiroxina seria inapropriado nesse contexto. A tireoidite subaguda costuma causar dor cervical e não está associada a exoftalmia. Anti-inflamatórios podem ser usados para alívio dos sintomas inflamatórios, mas não se aplicam a este caso.

Bibliografia: <https://www.uptodate.com/contents/diagnosis-of-hyperthyroidism>. Acessado em 04/02/2025.; <https://www.uptodate.com/contents/hyperthyroidism-in-nonpregnant-adults-overview-of-treatment>. Acessado em 04/02/2025.

93. Homem de 25 anos, previamente saudável, comparece à consulta apresentando secreção uretral purulenta há 4 dias, de cor esverdeada e acompanhada de disúria leve e sensação de prurido no meato uretral. Relata relação sexual desprotegida com parceiro eventual há aproximadamente 7 dias. Nega febre, dor testicular ou lesões cutâneas. Exame físico sem alterações significativas, exceto por leve hiperemia no meato uretral. Foi solicitado exame de secreção uretral e cultura. Diante do caso exposto, assinale a alternativa mais provável para o diagnóstico do paciente.
- A. Gonorreia.
 - B. Candidíase uretral.
 - C. Sífilis primária.
 - D. Herpes genital.

Alternativa Correta: **(A)** A secreção uretral purulenta, associada ao início agudo dos sintomas após exposição sexual desprotegida, é característica de uretrite gonocócica, causada pela *Neisseria gonorrhoeae*. A disúria leve e o prurido no meato uretral também são compatíveis com essa etiologia. Candidíase uretral: mais comum em pacientes imunocomprometidos, apresenta-se geralmente com prurido intenso e secreção esbranquiçada. Sífilis primária: caracteriza-se por úlcera genital indolor (cancro duro), o que não ocorre neste caso. Herpes genital: causa lesões vesiculosas ou ulceradas dolorosas na região genital.

Bibliografia: Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas (PCDT) - Atenção Integral às pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis - Ministério da Saúde, 2023. capítulo 5- Manejo integral das IST Sintomáticas.

94. Homem de 37 anos, apresenta-se ao consultório com histórico de hipertensão arterial persistente, em uso de Enalapril, anlodipino e hidroclorotiazida em doses adequadas. Ele relata medidas aleatórias domiciliares de pressão arterial com valores de pressão sistólica frequentemente acima de 160mmHg. Relata boa adesão medicamentosa. Ao exame físico, nota-se pressão arterial de 170/110 mmHg. O único achado digno de nota no exame físico são pulsos femorais de baixa amplitude. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

A. Hipertensão essencial de difícil controle.

B. Hipertensão secundária.

C. Hipertensão maligna.

D. Hipertensão mascarada

Alternativa Correta: **(B)** O quadro clínico apresentado é sugestivo de hipertensão secundária, com a principal hipótese diagnóstica sendo coarctação da aorta, dada a presença de pulsos femorais de baixa amplitude. Trata-se de um paciente jovem, sem fatores de risco para HAS essencial.

Bibliografia: HARRISON, T. R. Harrison's Principles of Internal Medicine. 21^a ed. New York: McGraw-Hill, 2022.

95. Homem de 58 anos, portador de hipertensão arterial e com diagnóstico recente de doença coronariana crônica, vem ao consultório para acompanhamento. Ele se queixa de dor torácica anginosa aos esforços habituais. Está em uso de atorvastatina, enalapril e hidroclorotiazida em doses adequadas. Ao exame físico, apresenta pressão arterial = 125/75 e frequência cardíaca = 80 bpm, sem outros achados dignos de nota. Qual das seguintes classes de medicamentos é a mais indicada para seu controle sintomático?

A. Nitrato sublingual conforme demanda.

B. Betabloqueador.

C. Nitrato de longa duração.

D. Bloqueador de canal de cálcio.

Alternativa Correta: **(B)** Os betabloqueadores são a primeira escolha no tratamento de angina estável e, neste caso, são a opção mais indicada para controle sintomático, já que o paciente não apresenta contra-indicações.

Bibliografia: HARRISON, T. R. Harrison's Principles of Internal Medicine. 21^a ed. New York: McGraw-Hill, 2022.

96. Homem de 55 anos, com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) e obesidade, recebe prescrição de um medicamento com ação agonista no receptor de GLP-1. Qual alternativa descreve corretamente os efeitos desse medicamento?

A. Aumento da resistência periférica à insulina, por diminuição da captação de glicose pelo músculo esquelético e pelos adipócitos.

B. Aumento da saciedade, retardo do esvaziamento gástrico e inibição da liberação de glucagon.

C. Estímulo à secreção de insulina pelas células beta, independente dos níveis de glicose.

D. Aumento da excreção de glicose na urina via inibição do cotransportador de sódio-glicose tipo 2.

Alternativa Correta: **(B)** Apresenta múltiplas ações: estimula a secreção de insulina de maneira glicose-dependente, inibe a secreção de glucagon e o débito hepático de glicose, retarda o esvaziamento gástrico, provoca saciedade, reduz o apetite e propicia perda ponderal. Além disso, melhora a sensibilidade periférica à insulina, com aumento da captação de glicose pelo músculo esquelético e adipócitos.

Bibliografia: VILAR, Lucio. Endocrinologia Clínica. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

97. Paciente de 100kg e 1,60m, internado na Unidade de Terapia Intensiva, evoluiu com piora do quadro geral, acompanhado de 100 ml de diurese nas últimas 12 horas. Pode-se afirmar que:

- A. existe insuficiência renal, com indicação de hemodiálise nas próximas 24 horas pela gravidade do caso.
- B. existe injúria renal aguda, indicada pela diurese menor que 0,5 ml/kg por hora nas últimas 12 horas.**
- C. o volume de diurese não é um bom marcador de insuficiência renal, devendo ser utilizado o valor da creatinina sérica.
- D. o volume de diurese apresentado caracteriza o quadro como insuficiência renal aguda estágio 3.

Alternativa Correta: **(B)** Segundo as diretrizes do KDIGO para diagnóstico e manejo da insuficiência renal aguda, a redução do volume de diurese a valores menores que 0,5mL por kg de peso por hora, por um período de 12 horas é critério para diagnosticar o quadro como INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA ESTÁGIO 2. O valor absoluto de creatinina e/ou ureia séricos não podem ser utilizados isoladamente como critério diagnóstico. O uso da variação da creatinina em relação ao valor basal e/ou redução do volume de diurese são os critérios aceitos e normatizados através das diretrizes supracitadas.

Bibliografia: 1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney inter., Suppl. 2012; 2: 1?138.

98. Homem de 73 anos, com história de hipertensão arterial sistêmica e diabetes tipo 2, ambos há mais de 15 anos, refere uso irregular de losartana e metformina. Iniciou há 1 dia com quadro súbito de hemiplegia direita proporcionada e afasia motora. Familiar refere episódio semelhante há 2 meses, com melhora espontânea em 30 minutos. Nega tabagismo. Ao exame PA: 200/100 mmHg, FC: irregular (80-100 bpm) Sat O₂: 96% (ar ambiente) e FR: 12 irpm. ECG: fibrilação atrial. TAC de crânio: área hipodensa fronto-temporo-parietal esquerda. Angiotomografia de carótidas e vertebrais: sem estenoses significativas. Qual a classificação etiológica do AVE-I (Toast) e o tratamento profilático adequado para após a alta hospitalar?
- A. Indeterminado. AAS + sinvastatina.
 - B. Indeterminado. Anticoagulante oral.
 - C. Cardioembólico. AAS + Clopidogrel.
 - D. Cardioembólico. Anticoagulante oral.**

Alternativa Correta: **(D)** No caso em questão o paciente apresenta síndrome de circulação anterior total (hemiplegia + disfunção cortical- linguagem) que ocorre ao ter oclusão de artéria carótida interna. Na investigação etiológica apresenta Fibrilação atrial, fonte de êmbolos e principal causador de AVE cardioembólico. Paciente teve quadro de AIT prévio, com HAS, DM-2 com CHADSVASC2 = 5 com indicação de uso de anticoagulante oral para evitar novos episódios de AVE.

Bibliografia: Manual de Rotinas para atenção ao AVC- Ministério da Saúde. 2013.

99. Mulher de 50 anos, iniciou dor simétrica em joelhos há 6 meses e piora progressiva. A dor é mais intensa no início dos movimentos e piora com esforço. Associado tem rigidez articular menor que 10 minutos. Ao exame físico observa-se peso de 67kg e altura de 1,45m, nódulos de Heberden e crepitação nos dois joelhos. Baseado no quadro acima, qual dos tratamentos abaixo é capaz de impedir a progressão da doença articular?
- A. Uso de analgésico simples contínuo.
 - B. Adotar medidas para redução de peso.**
 - C. Suplementação com colágeno oral.
 - D. Infiltração intra-articular com corticosteróide.

Alternativa Correta: **(B)** aluno deve perceber pelo quadro clínico o diagnóstico de osteoartrite (artrose): dor crônica e protocinética, presença de crepitação e nódulos de heberden em mãos (osteoartrite de mãos). Além do fator de risco - obesidade. O tratamento farmacológico com AINE, analgésicos e colágeno é apenas sintomático. A infiltração com corticosteróides tem ação antiinflamatória local, com alívio sintomático transitório. O único capaz de impedir a progressão da doença é a perda de peso.

Bibliografia: Reumatologia : diagnóstico e tratamento / Marco Antonio P. Carvalho ... [et al.]. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. Capítulo 18.

100. Mulher de 53 anos, refere quadro de uma semana de hipersensibilidade no couro cabeludo, cefaleia hemicraniana moderada e amaurose fugaz. Investigação laboratorial evidenciou velocidade de hemossedimentação de 100 mm/h. Neste caso, qual a hipótese diagnóstica mais provável?
- A. Cefaleia tensional.
 - B. Migrânea.

- C. Arterite de células gigantes.
- D. Cefaleia trigeminal autonômica.

Alternativa Correta: (C) A Arterite de células gigantes deve ser fortemente considerada em pacientes com mais de 50 anos, com elevação da VHS, apresentando nova cefaleia ou mudança nas características de cefaleia pre-existente, perda de visão transitória, claudicação mandibular, febre inexplicada ou sinais/sintomas de anormalidades vasculares (claudicação de membro, assimetria de pressão arterial entre membros, dor durante palpação da artéria temporal, dentre outros). A medida terapêutica inicial para os casos com manifestações visuais é Metilprednisolona IV, de 500 a1000 mg/dia, por 3 dias, seguido por prednisona oral (40 a 60 mg/dia) ou prednisona oral 1mg/kg/dia caso o pulso intravenoso não possa ser realizado rapidamente.

Bibliografia: BELDA JUNIOR, W.; DI CHIAICCHIO, N.; CRIADO, P. R. Tratado de dermatologia. São Paulo: Atheneu, 2018.

Ginecologia e Obstetrícia

101. Mulher de 31 anos vem à consulta ginecológica com laudo de citopatológico, cujo resultado é células escamosas atípicas de significado indeterminado possivelmente não neoplásicas (ASC-US). Segundo o Protocolo de Rastreamento do Câncer do Colo Uterino qual deverá ser a conduta para esta paciente?

- A. Colposcopia.
- B. Cauterização do colo do útero.
- C. Repetir citopatológico em 6 meses.
- D. Repetir citopatológico em 1 ano.

Alternativa Correta: (C) Em virtude da idade da paciente ser maior que 30 anos, o citopatológico deverá ser repetido precocemente (6 meses).

Bibliografia: Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Divisão de Detecção Precoce e Apoio . Organização de Rede. ? 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: INCA, 2016.

102. A Endocrinologia Ginecológica se refere aos aspectos fisiológicos, principalmente hormonais e reprodutivos, do funcionamento do corpo feminino desde o intra-útero até a senilidade, assim como suas patologias. Qual das seguintes condições é considerada uma endocrinopatia ginecológica comum?

- A. Infecção vaginal.
- B. Menopausa precoce.
- C. Síndrome dos ovários policísticos (SOP).
- D. Hiperplasia adrenal congênita.

Alternativa Correta: (C) A SOP é uma das endocrinopatias ginecológicas mais comuns, caracterizada por irregularidades menstruais e hiperandrogenismo. As outras opções podem estar relacionadas, mas não são tão prevalentes quanto a SOP.

Bibliografia: American College of Obstetricians and Gynecologists. (2021). "Síndrome dos Ovários Policísticos."Disponível em: www.acog.org.; Berek, J S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. 16 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

103. O atendimento adequado a mulheres vítimas de violência sexual é essencial para minimizar danos físicos e psicológicos. Sobre essa assistência, assinale a alternativa correta.

- A. A profilaxia para infecções sexualmente transmissíveis (IST) deve ser iniciada após confirmação laboratorial de infecção.
- B. A prescrição de medicações profiláticas para gravidez deve ser feita após a autorização judicial.
- C. O atendimento médico deve priorizar a coleta de provas para investigação, independentemente do desejo da vítima.
- D. A vítima tem direito à contracepção de emergência e profilaxia para IST, independentemente de realizar denúncia formal.

Alternativa Correta: (D) Toda mulher vítima de violência sexual tem direito ao atendimento emergencial, incluindo contracepção de emergência e profilaxia para IST, como HIV, sífilis e hepatites virais. Esses cuidados não dependem da realização de boletim de ocorrência. A coleta de provas para fins legais deve ser oferecida, mas nunca imposta. O tratamento das IST deve ser iniciado com base no risco epidemiológico, sem necessidade de exames prévios.

Bibliografia:BRASIL. Lei nº 12.845/2013 - Dispõe sobre atendimento obrigatório e integral de vítimas de violência sexual.; MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual, 2021.

104. Uma gestante de 28 anos, G1P0, 33 semanas, procura o pronto atendimento com queixa de febre (38,2°C), fadiga intensa, tosse seca e dispneia aos esforços há três dias. Relata que não recebeu vacinação contra COVID-19. Ao exame, apresenta frequência cardíaca de 105 bpm, pressão arterial de 110/70 mmHg, frequência respiratória de 24 irpm e saturação de 92% em ar ambiente. A ultrassonografia obstétrica mostra feto único, cefálico, com líquido amniótico normal e ausência de sofrimento fetal. Com base no manejo adequado da COVID-19 na gestação, assinale a alternativa correta.

- A. Internação hospitalar e administração de suporte com oxigênio, corticoides para maturação pulmonar fetal e anti-coagulação profilática, considerando o risco aumentado de tromboembolismo na COVID-19.
- B. Indicação de cesariana emergencial para reduzir o risco de transmissão vertical e prevenir complicações maternas
- C. Administração de antibióticos empíricos para prevenir pneumonia bacteriana secundária, mesmo sem sinais de coinfeção.
- D. Uso de antivirais específicos, como remdesivir, para todas as gestantes com COVID-19, independentemente do quadro clínico.

Alternativa Correta: (A) O caso acima demonstra um quadro de Síndrome Respiratória Aguda na gestação. Tendo em vista o quadro grave com alteração de sinais vitais e dessaturação, a conduta indicada é internação da gestante para suporte com oxigenioterapia. A indicação de corticoterapia se aplica tendo em vista o quadro grave materno e a possibilidade de interrupção da gestação para melhora da hemodinâmica materna. Como se trata de uma gestação entre 24-34 semanas, está indicada tal conduta. Uso profilático de anticoagulante está indicado tendo em vista de tromboembolismo em gestante com suspeita de SARS-COV-2.

Bibliografia: Ministério da Saúde (Brasil). Nota Técnica nº 07/2021-SECOVID/GAB/MS. Manejo da infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) na gestação e puerpério. Disponível em: <https://www.gov.br/saude>. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). Recomendações para assistência a gestantes e puérperas frente à pandemia de COVID-19. São Paulo: FEBRASGO, 2021. Disponível em: <https://www.febrasgo.org.br>.

105. O climatério pode dividido em pré e pós menopáusico caracterizado por importante mudanças no estado de saúde e qualidade de vida das mulheres ocasionado pela redução da resposta ovariana às gonadotrofinas e depleção dos oócitos. Achados frequentes neste período de vida feminina são:

- A. sintomas frequentes como ondas de calor e suores noturno, aumento da gordura abdominal, elevação do FSH, a estrona torna se o principal estrogênio circulante.
- B. aumento da incidência de osteoporose, alterações da qualidade do sono, aumento nível do estradiol, redução nível do colesterol total.
- C. sintomas depressivos, atrofia urogenital, aumento da inibina beta, elevação no hormônio anti mulleriano.
- D. aumento no risco cardio vascular, piora na qualidade do sono, maior incidência do DM, redução estradiol, redução das gonodotrofinas.

Alternativa Correta: (A) A menor produção da inibina beta ocasionando redução da resposta ovariana às gonotrofinas com depleção do oócitos, esta menor formação de folículos antrais reduzirá os níveis do hormônio antimulleriano. O não desenvolvimento folicular reduzirá as secreções do estradiol permanecendo o ovário com a produção apenas de andrógenos e no tecido gorduroso se converterá em estrona (principal estrogênio circulante na pós menopausa).

Bibliografia: Fernandes, C.E.; Pompei L.M. ENDOCRINOLOGIA FEMININA.

106. Mulher de 28 anos, procura o pronto-socorro com queixa de dor pélvica há três meses. Ela descreve a dor como difusa, de intensidade moderada, piorando no período menstrual e durante a relação sexual. Relata ciclos menstruais regulares, sem sangramentos anormais. Nega febre, alterações urinárias ou gastrointestinais importantes. Exame físico revela leve dor à palpação do hipogástrio e mobilização do colo uterino dolorosa. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A. Endometriose.
- B. Doença inflamatória pélvica (DIP).
- C. Cistite intersticial.
- D. Apendicite crônica.

Alternativa Correta: (A) Embora a DIP possa causar dor pélvica crônica em alguns casos, é mais comum a apresentação aguda com febre, corrimento vaginal e sinais inflamatórios mais evidentes no exame físico. A dor pélvica cíclica, piorando na menstruação (dismenorreia) e na relação sexual (dispareunia), é altamente sugestiva de endometriose. A sensibilidade à mobilização do colo pode indicar aderências causadas pela doença. A cistite intersticial causa dor pélvica crônica, mas geralmente

está associada a sintomas urinários, como urgência e aumento da frequência urinária. Apendicite normalmente causa dor aguda no quadrante inferior direito e sinais inflamatórios sistêmicos. Formas crônicas são raras e não se apresentam de maneira cíclica.

Bibliografia: Zondervan KT, Becker CM, Missmer SA. Endometriosis. N Engl J Med. 2020;382(13):1244-1256.; Morassutto C, Monasta L, Ricci G, Barbone F, Ronfani L. Incidence and prevalence of endometriosis: a data-driven systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2016;22(3): 374-388.; Hanno PM, Burks DA, Clemens JQ, et al. Diagnosis and treatment of interstitial cystitis/bladder pain syndrome. J Urol. 2011;185(6):2162-2170.

107. Gestante a termo chega no Centro Obstétrico com dor abdominal intensa, súbita, associada a sangramento vaginal e parada de movimentação fetal. Apresenta hipertonia uterina, ausência de batimentos fetais, colo impérvio e sangramento vaginal moderado. O fator de risco mais frequentemente associado a essa intercorrência obstétrica é:

- A. hipertensão arterial.
- B. cirurgia uterina prévia.
- C. obesidade.
- D. idade materna abaixo de 20 anos.

Alternativa Correta: (A) A principal causa do descolamento prematuro de placenta é desconhecida. Contudo, vários fatores de risco foram identificados, sendo a hipertensão arterial materna o principal fator etiológico ocorrendo em cerca de 44% de todos os casos.

Bibliografia: Zugaib Obstetrícia - Marcelo Zugaib (Editor), Rossana Pulcineli Vieira Francisco (Coeditor) ? 5ª ed. Manole - 2023.

108. Uma gestante de 8 semanas de idade gestacional, sem comorbidades prévias, realiza exames de primeira rotina e apresenta TSH de 5,5 mUI/L e T4 livre dentro da normalidade. Ela está assintomática e não tem histórico prévio de doenças tireoidianas. Qual é a conduta mais adequada para essa paciente?

- A. Repetir a dosagem de TSH em 4 semanas para reavaliação antes de qualquer intervenção.
- B. Iniciar levotiroxina na dose de 1 mcg/kg/dia, independentemente de outros fatores.
- C. Solicitar anticorpos antitireoidianos (ATPO) e, se positivo, iniciar levotiroxina na dose de 1 mcg/kg/dia.
- D. Não iniciar tratamento, pois o TSH está abaixo de 10 mUI/L, apenas monitorar.

Alternativa Correta: (C) De acordo com a Febrasgo, se a gestante apresentar hipotireoidismo subclínico (TSH entre 4,0 e 10,0 mUI/L com T4 livre normal), a conduta depende da dosagem dos anticorpos antitireoidianos (ATPO): Se ATPO positivo: iniciar levotiroxina (1 mcg/kg/dia). Se ATPO negativo: conduta individualizada, podendo apenas monitorar.

Bibliografia: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). "Rastreamento, diagnóstico e manejo do hipotireoidismo na gestação." Femina, vol. 50, nº 10, 30 de outubro de 2022, pp. 607-617.

109. Gestante de 32 semanas, previamente normotensa, comparece ao pronto atendimento com cefaleia intensa, turvação visual e dor epigástrica. Ao exame, apresenta pressão arterial de 170/110 mmHg e reflexos tendíneos exaltados. O exame de urina tipo 1 revela proteinúria de 2+. Qual a conduta imediata mais apropriada?

- A. Expectante, com repouso domiciliar e controle pressórico ambulatorial semanalmente.
- B. Administração de sulfato de magnésio, anti-hipertensivos e avaliação da necessidade de interrupção da gestação.
- C. Uso de metildopa como anti-hipertensivo e acompanhamento clínico ambulatorial semanalmente.
- D. Reavaliação em 48 horas para monitoramento da pressão arterial antes de definir conduta.

Alternativa Correta: (B) A paciente apresenta pré-eclâmpsia grave, caracterizada por hipertensão grave (PA ≥ 160/110 mmHg), sintomas de iminência de eclâmpsia (cefaleia intensa, turvação visual, dor epigástrica) e proteinúria. A conduta inclui: Sulfato de magnésio para prevenção de convulsões (eclâmpsia), Anti-hipertensivos de ação rápida (ex: hidralazina ou labetalol IV) para controle da PA, Avaliação da vitalidade fetal e idade gestacional para decidir sobre a interrupção da gestação, sendo esta a única cura definitiva da doença. O manejo expectante ou ambulatorial está contraindicado diante da gravidade do quadro.

Bibliografia: Peraçoli JC, Costa ML, et al. Pré-eclâmpsia - Protocolo 2023. Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez (RBEHG), 2023.

110. A ruptura prematura de membranas (RUPREME) é a ruptura das membranas amnióticas antes do início do trabalho de parto, podendo ocorrer a termo (maior ou igual a 37 semanas de gestação) ou pré-termo (menor que 37 semanas de gestação). Assinale a assertiva correta RUPREME em gestantes atendidas em hospital terciário.

- A. Na RUPREME pré-termo com conduta conservadora, deve-se utilizar nifedipina até a 34ª semana para impedir o trabalho de parto prematuro.
- B. Se a idade gestacional for maior que 34 semanas, deve-se utilizar sulfato de magnésio para neuroproteção por 12 horas antes de interromper a gestação.
- C. Caso a interrupção da gestação ocorra após a 34ª semana, não há necessidade de profilaxia para Streptococcus do grupo B se o estado da colonização for desconhecido.
- D. Para gestantes em qualquer idade gestacional, se houver diagnóstico de infecção intrauterina, estão indicadas internação e interrupção da gestação.

Alternativa Correta: (D) Os tocolíticos, como a nifedipina devem ser utilizados por no máximo 48h, tempo necessário para a corticoterapia. O sulfato de magnésio está indicado para neuroproteção fetal até 32 semanas. A profilaxia para estreptococos do grupo B deve ser feita para todas as gestantes com rotura prematura pré-termo de membranas se a cultura for desconhecida ou positiva. É preconizada a interrupção da gravidez em caso de trabalho de parto ativo, infecção intrauterina e quando há comprometimento da vitalidade fetal

Bibliografia: American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Practice Bulletins. Practice Bulletin No.172: Premature Rupture of Membranes. Obstetrics, Obstet Gynecol, 2016.; Amniorrexe prematura e corioamnionite. Manual Técnico de Gestação de Alto Risco. Ministério da Saúde. 2012.; Galletta MAK. Rotura prematura de membranas ovulares. Protocolos Assistenciais FMUSP. 5ªed p505-13, 2015.

111. Paciente 14 anos de idade é levada à consulta na UBS pela mãe. Relata que a adolescente ainda não menstruou e que está preocupada quando a compara com as amigas da filha. Ao exame físico apresenta estágio puberal M4 e P4 (desenvolvimento observado após os 11 anos) de Tanner, hímen presente e íntegro. Nesse contexto, assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico provável e a orientação médica correta, respectivamente.
- A. Síndrome de Turner; solicitar cariótipo.
 - B. Puberdade tardia; dosagem de FSH e LH.
 - C. Puberdade normal; orientação sem necessidade de exame adicional.
 - D. Síndrome dos ovários policísticos; antimülleriano e ultrassonografia pélvica.

Alternativa Correta: (C) A definição de amenorreia primária segue um critério cronológico: ausência de menstruação aos 13 anos com falta de desenvolvimento sexual ou ausência de menstruação aos 15 anos, mesmo com desenvolvimento sexual normal. Na paciente observa-se que ela apresenta desenvolvimento normal das mamas e pelos (M4 e P4 de Tanner), indicando o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários. Como a menstruação é o último dos eventos fisiológicos do desenvolvimento sexual, ela provavelmente ocorrerá nos próximos meses. A investigação se iniciaria imediatamente caso ela não tivesse qualquer desenvolvimento sexual secundário (M1 e P1 de Tanner). Por fim, pelos motivos explicados anteriormente, não há necessidade de realização de qualquer exame subsidiário neste momento. É uma consulta comum no grupo de adolescentes que ainda não menstruaram e são levadas ao médico por familiares. Apenas a orientação de que ela deve menstruar logo.

Bibliografia: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). Amenorreia. São Paulo: FEBRASGO; 2021. (Protocolo FEBRASGO-Ginecologia, n. 25/Comissão Nacional Especializada em Ginecologia Endócrina).

112. Gestante de 18 semanas apresenta VDRL 1:64 e FTA-ABs positivo. Nega realização de tratamento anterior e afirma ser alérgica à penicilina. Qual o tratamento a ser realizado?
- A. Doxiciclina.
 - B. Estolato de eritromicina.
 - C. Penicilina, após prévia dessensibilização.
 - D. Tetraciclina.

Alternativa Correta: (C) O tratamento para sífilis é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a benzilpenicilina benzatina o medicamento de escolha e a única droga com eficácia durante a gestação.

Bibliografia: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Manual de Gestação de Alto Risco [recurso eletrônico] / High-risk pregnancy manual. 1ª edição - 2022 -versão preliminar. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Link para o arquivo. Pg 232.

113. Uma paciente de 35 anos, nuligesta, com histórico de dismenorreia severa e dispareunia profunda, tenta engravidar há 2 anos sem sucesso. Foi diagnosticada com endometriose ovariana e profunda através de ressonância magnética. Seu parceiro apresenta espermograma normal e os demais exames para investigação de infertilidade da paciente não apresentam alterações. Assinale a alternativa que representa a melhor estratégia terapêutica para essa paciente, visando uma gestação a curto prazo.

- A. Realizar estimulação ovariana com coito programado, pois ainda há chances de gestação espontânea.
- B. Indicar tratamento cirúrgico para remoção das lesões antes de qualquer tentativa de reprodução assistida.
- C. Prescrever contraceptivos hormonais para controle da progressão da endometriose antes de tentar engravidar.
- D. Encaminhar diretamente para fertilização in vitro (FIV), considerando o impacto da endometriose na fertilidade.

Alternativa Correta: **(D)** O coito programado tem baixa eficácia em pacientes com endometriose avançada e infertilidade prolongada. A cirurgia pode ser considerada para melhoria da qualidade de vida e sintomas, mas a FIV é a conduta mais indicada nesse caso para otimizar as chances de gravidez em casos de infertilidade relacionada à endometriose. Apesar da paciente poder se beneficiar da cirurgia para melhora dos sintomas, o tratamento indicado de maior eficácia para tratamento de endometriose e infertilidade é a FIV tornando a alternativa correta. O uso de contraceptivos não é adequado para uma paciente que deseja engravidar a curto prazo.

Bibliografia: ESHRE Endometriosis Guideline Development Group. Diretriz da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia: Endometriose. Europeu <https://www.eshre.eu/diretrizes>.

114. A respeito da infecção e transmissão do HIV para a prole, assinale a conduta mais adequada visando diminuir o risco de infecção ao feto.
- A. Para as gestantes soropositivas deve-se indicar, preferencialmente a cesárea eletiva, independente da carga viral.
 - B. A utilização da terapia antirretroviral combinada durante a gestação deve ser recomendada juntamente com a não amamentação.
 - C. A terapêutica profilática com antirretrovirais deve ser implementada apenas no neonato, pois a transmissão ocorre predominantemente no momento do parto.
 - D. Recomenda-se implementar a terapia antirretroviral apenas no terceiro trimestre de gestação visando evitar a toxicidade fetal

Alternativa Correta: **(B)** A cesárea eletiva é indicada apenas para gestantes com carga viral detectável ou desconhecida no final da gestação. A terapia antirretroviral deve ser iniciada o mais precocemente possível, idealmente no primeiro trimestre ou logo após o diagnóstico. A transmissão vertical ocorre frequentemente no parto, mas profilaxia no recém-nascido é apenas uma parte da abordagem. A supressão viral materna durante a gestação é essencial para prevenir a transmissão intraútero e periparto.

Bibliografia: Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos. Disponível em: www.gov.br/saude.

115. A incontinência urinária (IU) e os prolapso dos órgãos pélvicos (POP) são condições frequentes em mulheres, especialmente com o avanço da idade. Sobre a epidemiologia e a fisiopatologia dessas condições, assinale a alternativa correta.
- A. O prolapso de órgãos pélvicos é raro em mulheres multíparas e está mais associado a fatores genéticos do que a fatores mecânicos.
 - B. A incontinência urinária de esforço (IUE) ocorre devido à fraqueza do suporte uretral e do assoalho pélvico, sendo mais comum em mulheres que tiveram partos vaginais.
 - C. A incontinência urinária de urgência (IUU) ocorre exclusivamente devido a fatores mecânicos, sem relação com disfunções neuromusculares.
 - D. O tratamento cirúrgico é indicado como primeira linha para todas as mulheres com prolapso de órgãos pélvicos, independentemente do grau dos sintomas.

Alternativa Correta: **(B)** A IUE resulta da fraqueza do suporte do assoalho pélvico e do esfíncter uretral, frequentemente associada ao parto vaginal e à deficiência estrogênica.

Bibliografia: Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Incontinência Urinária e Prolapso dos Órgãos Pélvicos. Disponível em: www.sbu.org.br.

116. O sangramento uterino anormal (SUA) é um distúrbio ginecológico comum, podendo estar associado a causas estruturais e não estruturais, conforme a classificação PALM-COEIN estabelecida pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO). Assinale a alternativa correta.
- A. O SUA associado à adenomiose é caracterizado por aumento uterino difuso e dor pélvica progressiva, sendo a ultrassonografia transvaginal e a ressonância magnética métodos úteis para o diagnóstico da doença.

- B. Os miomas submucosos, classificados no sistema PALM-COEIN, raramente causam SUA, pois não interferem na vascularização endometrial e no processo de contração uterina, sendo necessários apenas em casos sintomáticos.
- C. No manejo do SUA, os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são a primeira linha de tratamento, pois reduzem o volume do sangramento e promovem inibição completa da proliferação endometrial, eliminando a necessidade de terapias hormonais.
- D. O SUA de origem anovulatória ocorre por deficiência na produção de estrogênio, levando a atrofia endometrial e consequente sangramento irregular, sendo mais frequente em mulheres na pós-menopausa.

Alternativa Correta: **(A)** O SUA pode ser causado por alterações estruturais (PALM), como pólipos, adenomiose, leiomiomas e malignidade, ou não estruturais (COEIN), incluindo coagulopatias, disfunção ovulatória, endometriais, iatrogênicas e não classificadas. O SUA anovulatório é causado pela produção sustentada de estrogênio sem oposição da progesterona, resultando em proliferação endometrial excessiva, não atrofia. Os miomas submucosos frequentemente causam SUA, pois alteram a vascularização e reduzem a contratilidade uterina, levando a sangramentos volumosos e prolongados. A adenomiose está associada a SUA, dor pélvica progressiva e dismenorreia, sendo a ultrassonografia transvaginal e a ressonância magnética essenciais para o diagnóstico. Os AINEs reduzem o volume do sangramento por inibição da prostaglandina endometrial, mas não substituem as terapias hormonais, sendo apenas adjuvantes no tratamento.

Bibliografia: Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes para o manejo do Sangramento Uterino Anormal. Brasília: MS, 2022.; American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Abnormal Uterine Bleeding: Evaluation and Management. Obstet Gynecol. 2021;137(6):e29-e52.

117. Paciente de 40 anos, Gesta III, Para III, em tratamento para Lúpus Eritematoso Sistêmico usando prednisona e metotrexate, vem à consulta para orientação anticoncepcional. Pelos critérios de elegibilidade, qual método contraceptivo de escolha?
- A. Combinado oral bifásico.
 - B. Combinado oral trifásico.
 - C. Injetável Mensal.
 - D. Sistema Intra-Uterino de Levonorgestrel.

Alternativa Correta: **(D)** Pelos critérios de elegibilidade, a paciente lúpica tem maior risco tromboembólico devendo-se evitar o uso de estrogênio na contracepção. Os métodos de barreira podem ser utilizados, porém com baixa eficácia. O sistema intra-uterino de levonorgestrel é o mais indicado.

Bibliografia: Finotti, Marta Manual de anticoncepção / Marta Finotti. – São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 2015.

118. Primigesta, 32 semanas de gestação, comparece a Unidade de Saúde para consulta de rotina. Está fazendo pré-natal regularmente e não apresenta comorbidades. Relata movimentação fetal e não apresenta outras queixas. Ao exame físico: corada, hidratada e eupneica. Qual alternativa contempla o exame físico mínimo a ser realizado nesta gestante?
- A. Altura uterina, ultrassonografia, batimento cardíaco fetal, registro de movimento fetal.
 - B. Peso materno, circunferência abdominal, batimento cardíaco fetal, toque vaginal.
 - C. Pressão arterial, altura uterina, ultrassonografia, batimento cardíaco fetal, toque vaginal.
 - D. Peso materno, pressão arterial, altura uterina, batimento cardíaco fetal.

Alternativa Correta: **(D)** Circunferência abdominal não faz parte do exame obstétrico, toque vaginal e ultrassonografia não são obrigatórios realizar em todas as consultas.

Bibliografia: Zugaib Obstetrícia / Marcelo Zugaib [et al.] 4a. ed. São Paulo: Pulcinelli, 2020.

119. Na assistência à gestante com diabetes mellitus gestacional (DMG), o controle glicêmico adequado é relevante na morbimortalidade materna e perinatal para evitar complicações. São complicações do DMG:
- A. restrição do crescimento intrauterino, oligodramnia.
 - B. polidramnio, macrossomia fetal.
 - C. proteinúria, convulsão
 - D. esquizócitos em esfregaço de sangue periférico, polidramnia.

Alternativa Correta: **(B)** No Brasil, estima-se que 18% das mulheres grávidas, assistidas no Sistema Único de Saúde (SUS), atinjam os critérios diagnósticos atuais de DMG. Entre os fatores de risco, destacam-se: obesidade, idade materna superior a 25 anos, história familiar e/ou pessoal positiva, gemelidade, hipertensão arterial, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, macrossomia pregressa, óbito fetal sem causa aparente, entre outros. As complicações clássicas e mais prevalentes do DMG são o polidramnio, a macrossomia fetal e a distócia de ombro.

Bibliografia: Zugaib Obstetrícia / Marcelo Zugaib ... [et al.] 4a. ed. - São Paulo: Pulcinelli, 2020.

120. Qual exame faz o diagnóstico definitivo de tumor maligno de mama, em mulher de 58 anos com nódulo duro e irregular na palpação?
- A. Ressonância magnética de mamas.
 - B. Punção percutânea com agulha grossa - *Core biopsy*.
 - C. Mamografia.
 - D. Ultrassonografia mamária.

Alternativa Correta: **(B)** O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo. O número estimado de casos novos de câncer de mama no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), para o triênio de 2023 a 2025, é de 73.610 casos. Também é a maior causa de morte por câncer nas mulheres em todo o mundo. O diagnóstico definitivo de câncer de mama somente pode ser estabelecido mediante uma biópsia histológica (biópsia com agulha grossa ou core biopsy). Mamografia e Ressonância magnética de mamas são exames que podem auxiliar na detecção, porém não são exames definitivos para diagnóstico do câncer de mama. Também a punção aspirativa com agulha fina- PAAF, é um exame citológico, o definitivo é com histologia.

Bibliografia: 1-<https://www.inca.gov.br/>; Estimativa 2023 : incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer. - Rio de Janeiro : INCA, 2022.; Doenças da mama: guia de bolso baseado em evidências, 3ª edição, Rio De Janeiro, Atheneu, 2022; Mastologia : Do Diagnóstico ao tratamento(livro eletrônico), Goiânia: Conexão Propaganda e Editora, 2017